U.F. 0123 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES EN DOMICILIO.

1. ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL

1.1. MANTENIMIENTO Y ENTRENAMIENTO DE HÁBITOS DE AUTONOMÍA FÍSICA EN SITUACIONES COTIDIANAS DEL DOMICILIO

Como ya hemos tratado este tema con anterioridad (Unidad Formativa 122, punto 5.1.) recomendamos en primer lugar volver a leerlo de nuevo.

Entendemos por **hábitos de autonomía física** aquellos relacionados con la capacidad de realizar físicamente y de forma autónoma las AVD (Actividades de la Vida Diaria).

Por ejemplo, una persona con hemiplejia necesitará aprender a realizar los movimientos para comer, vestirse, asearse... de acuerdo a las capacidades que aún mantenga. Tendrá que aprender a manejar su lado sano y aprender a utilizar productos de apoyo adaptados (antes llamadas ayudas técnicas) .

Fases de la intervención en el mantenimiento y entrenamiento de los hábitos de autonomía física en las situaciones cotidianas

El profesional de apoyo en domicilio deberá intervenir para mantener y entrenar los hábitos de autonomía física en las situaciones cotidianas en 4 fases diferentes:

1º PLANIFICAR ⇨ 2º PREPARAR ⇨ 3º ENTRENAR ⇨ 4º EVALUAR

1. **Planificar la intervención**: para ello deberá **observar** al usuario para **conocer sus capacidades residuales** (las que aún conserva), después establecerá un plan realista (evitar exigencias elevadas, ya que pueden ser frustrantes para la persona con dependencia). Determinará los **objetivos** que quiere conseguir (qué quiere mantener o entrenar) y cómo va a **evaluar** la intervención. Este plan lo tendrá que plasmar por escrito.

2. **Prepararse para la intervención**: deberemos crear un clima de confianza para que el usuario se sienta motivado, y deberemos explicarle la importancia de entrenar los hábitos de autonomía para su propio bienestar.
3. **Entrenar los hábitos** de autonomía física: para ello aportaremos los productos de apoyo necesarios para realizar la acción. Deberemos asesorar al usuario, proporcionarle oportunidades para que pueda poner en práctica esos hábitos dejándole el tiempo necesario. Aprovecharemos las situaciones cotidianas para entrenar los hábitos.

4. **Realizar el Seguimiento y la Evaluación:** Cada cierto tiempo comprobaremos los avances conseguidos, nos plantearemos si es oportuno introducir cambios en el plan o qué intervenciones vamos a mantener.

Por ejemplo, siguiendo el caso de la persona con hemiplejia. Establecido un clima de confianza, el usuario puede expresar libremente que no puede comer solo porque no puede agarrar los cubiertos:

- "No es que no quiera comer solo, es que no puedo agarrar los cubiertos".
- "No te preocupes, iremos poco a poco, muéstrame como lo haces y veremos como podemos mejorar".

El cuidador mantiene una postura abierta, y cordial, y tal vez pueda proporcionarle cubiertos adaptados y enseñarle a utilizarlos. Deberá permitirle acostumbrarse, darle tiempo, que experimente con diferentes tipos de comidas y texturas.
Para finalizar se comprobará si está comiendo de forma autónoma, si usa correctamente los cubiertos adaptados, o si se cansa, si nos anticipamos y para terminar antes interviene algún familiar o el técnico.

1.2. CONDICIONES DEL DOMICILIO

El ambiente en el que viven las personas es muy importante para poder realizar las actividades de forma autónoma, además tiene gran importancia en el estado de ánimo. Cada familia tiene acondicionado el domicilio según sus preferencias. La prestación del servicio en domicilio tiene sus aspectos positivos, pero también sus aspectos negativos.

- **Aspectos positivos**:

- Es un espacio conocido para el usuario, lo cual le aporta seguridad, tranquilidad, minimiza el estrés, siente que puede continuar su vida.
- Mantiene sus redes sociales (vecinos, amigos...)

- **Aspectos negativos**:

- Los domicilios no suelen estar adaptados (por ej. los baños no tienen asideros, las camas no son articuladas…) lo cual supone un desembolso económico, obras… para asegurar unos mínimos.

CONDICIONES que debe reunir el domicilio:

- **Seguridad:** Debe estar en unas condiciones que no pongan en riesgo la salud de la persona.
- **Accesibilidad:** Se deben procurar las máximas condiciones de accesibilidad, adecuadas a las características de la persona.
- **Confortabilidad**: el hogar debe de ser acogedor, cómodo, respetando los gustos personales.
- **Estimulación:** debe permitir ver el sol, escuchar sonidos del exterior, favorecer la orientación, la identificación de las estancias, así como la decoración debe favorecer la orientación personal (quién soy, quienes son mi familia, mis amigos…).
- **Ruido** : Por encima de los 70dB puede causar daños fisiológicos, además pueden aparecer barreras en la comunicación. El doble acristalamiento o recubrir las paredes con materiales fonoabsorbentes puede ayudar a disminuir los ruidos.
- **Iluminación**: puede ser natural, artificial o mixta, Es importante aprovechar la luz natural, pero dependiendo de las tareas a realizar nos apoyaremos de luz artificial. En la cocina, baños y pasillo necesitaremos una buena iluminación, mientras que en la sala de estar una luz cálida y menos potente será suficiente.
- **Temperatura**: Un exceso de frío dificulta las destrezas manuales, genera malestar y aislamiento; mientras que un exceso de calor provoca rápidamente el agotamiento, disminuye el deseo de interactuar con otras personas. Debemos de procurar una temperatura constante en todas las habitaciones (sobre todo en aquellas que el usuario pasa más tiempo).
- **Ventilación y humedad**: es importante mantener un grado apropiado de humedad y ventilación para evitar malestar que influya de forma negativa en las relaciones.

1.3. DISTRIBUCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS, MOBILIARIO Y ENSERES.

Este punto también ha sido tratado en los puntos 4 y 4.1. de la unidad Formativa 122, por lo que conviene releerlo.

Un domicilio que no sea accesible, que no reúna las condiciones necesarias, provocará un sentimiento de vulnerabilidad y de inutilidad en los usuario ("ya no

soy capaz"...); pero la persona no tiene que sentirse culpable, deberemos de intentar que las condiciones del domicilio sean las más idóneas posibles.

Una distribución adecuada de los espacios, los muebles y enseres, será aquella que se adapte a las características funcionales y físicas de las personas que viven en ella. Es muy probable que el domicilio no esté adaptado a las nuevas necesidades (situaciones de dependencia), por lo que habrá que actualizar los espacios.

- **Acceso al domicilio**: en el caso de que la persona necesite utilizar silla de ruedas y que haya que salvar uno o dos escalones, deberá actualizarse con rampas, si no es posible se optará por rampas portátiles ligeras, que puedan colocarse y retirarse después de utilizarse.
- **En el interior del domicilio**:
  - Las alfombras tienen que evitarse o fijarse al suelo con cinta adhesiva para evitar tropiezos y resbalones.
  - Suelo antideslizante y sin irregularidades.
  - Pasillos iluminados, despejados y evitando dejar objetos para minimizar tropiezos. Se puede colocar barandilla para que la persona pueda caminar.
  - Sistemas de protección en las ventanas.
  - Muebles y estanterías estables o fijadas en la pared.
  - Cierres de seguridad en armarios, cajones.
  - Esquinas de los muebles redondeadas, cantoneras en esquinas.
  - Puertas con manivela no pomos giratorios.
  - Detectores de humos y gas.
  - Sistemas de comunicación con el exterior accesibles (tfno, interfono)
  - En las viviendas con más de una planta, procuraremos ubicar a la persona con dependencia en la planta baja, si no fuera posible colocaremos una plataforma elevadora para que pueda desplazarse entre una y otra planta.

1.3.1. <u>Indicaciones para la actualización del salón, dormitorio, baño y cocina</u>

Salón:

- Cantoneras, bordes de muebles redondeados (para evitar que se haga daño en caso de golpes).
- Muebles bien fijados, de limpieza sencilla.
- Preferible que las mesas no sean de cristal (para evitar cortes en caso de rotura).
- Sillas cómodas y de altura adecuada para que pueda levantarse y sentarse con seguridad.

- Sofás ni demasiado bajos, ni demasiado mullidos, con reposabrazos (apoyo para incorporarse)
- Dejar un espacio libre de 90 cm y 1,50 m para giros en caso de silla de ruedas.

Dormitorio

- Cama con acceso por ambos lados, altura adecuada (entre 35 y 40 cm para usuarios con movilidad y hasta 80cm para personas con dependencia física).
- Colchón de látex que se adapte al cuerpo.
- Somier de láminas de madera.
- Cama articulada para quienes deben permanecer mucho tiempo en ella.
- Barandillas (evitar caídas) o estribos para facilitar cambios posturales
- El cabecero y piecero pueden ser de ayuda para acostarse, levantarse..
- Piloto de luz, para facilitar la orientación por la noche, indicar el camino al baño también resulta de ayuda.
- Mesilla estable, sin ruedas.
- Lámparas fijadas en la pared.
- Anchura mínima para paso de silla de ruedas 90cm y 150 cm para giros.
- Esquinas y bordes de muebles redondeados

Baño

- suelo antideslizante.
- apertura de puerta hacia fuera para ganar espacio.
- sanitarios con asideros de apoyo para facilitar el acceso a ducha e inodoro.
- Acceso al lavabo libre (sin pie ni mueble para permitir el acceso desde silla de ruedas).
- Espejo abatible.
- Altura más adecuada del inodoro en 45 cm para facilitar la transferencia de silla a WC.
- Ducha preferible a bañera, sin plato para acceso con silla, suelo antideslizante.
- Grifería mono mando.

Cocina

- Altura de muebles adecuada a la persona.
- Disposición de la vajilla, utensilios y alimentos donde sea fácil el acceso, cerca de la zona donde se va a utilizar.
- Encimeras lisas, con color en contraste para poder localizar con facilidad los objetos, superficies despejadas para facilitar el trabajo.
- Iluminación adecuada y reforzada en zonas de trabajo.
- Grifos monomando.
- Vajilla y vasos NO deben ser transparentes (las personas con déficit visual no los perciben). Mejor de plástico duro o material irrompible.
- Suelo antideslizante

- La cocina de inducción es la más segura porque mantiene fría la superficie. Las de gas son menos recomendables por riesgo de asfixia o de explosión.
- Horno eléctrico preferible al de gas.
- Productos de limpieza siempre deben guardarse en envase original para poder identificarlos con facilidad, guardado bajo llave si existiera riesgo de ser ingeridos.

1.3.2. Señales para facilitar la orientación en el domicilio

Podemos utilizar 3 tipos de señales para facilitar la orientación en el domicilio:

a) **Visuales**: Para personas con déficit auditivo, cognitivo o déficit visual parcial.
   -Señales luminosas que indiquen el camino desde el dormitorio hasta el baño.
   -Carteles que señalicen las diferentes estancias, y nombres en los enseres.
   -Dispositivos que se iluminen cuando suene el teléfono, el timbre, un escape de gas o humo...

b) **Auditivas**: Para personas con déficit visual.
   -El sonido del microondas cuando ha finalizado su tiempo programado.
   -El dispositivo de aviso de puerta abierta del frigorífico.
   -Alarmas sonoras en caso de escape de gas o humo.

c) **Tactiles**: Para personas con déficit visual.
   -carteles en Braille representando las estancias y enseres.
   -carteles en Braille para los programas de lavado del lavavajillas, lavadora, horno..
   -Franjas fijadas en el suelo antes de los escalones.
   -Pavimentos de diferentes texturas.

Conclusión: el auxiliar en apoyo a domicilio podrá identificar los aspectos que dificultan las realización de forma autónoma de las AVD y aconsejar sobre la distribución, actualización y señalización necesarios para facilitar la autonomía del usuario.

1.4. INTERVENCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA RESOLUCIÓN DE GESTIONES Y EN EL ENTORNO FAMILIAR

Este tema ya se ha visto con anterioridad en el punto 5.5. de la Unidad formativa 122, por lo que recomendamos su relectura.

El servicio de **acompañamiento consiste en** atender a la persona de forma integral, centrándose es sus potencialidades y apoyarla para que pueda desarrollarse por sí misma, o participar en la medida de lo posible en las AVD Básicas e Instrumentales, en las actividades de comunicación y en la relación social.

Para ello es necesario:

- Aprender a escuchar: atender a la persona, no sólo a lo que creemos saber.
- Aprender a mirar: estar atento a sus posibilidades y ayudarle a que tome conciencia de ellas y ayudarle a que pueda cambiar su imagen y pueda desarrollarlas.
- Dejarse transformar por el otro: implica un aprendizaje bidireccional, es decir, de las dos partes (del técnico y del usuario).

Las intervenciones que va a desarrollar el profesional desde el acompañamiento para mejorar el desarrollo de hábitos de autonomía física deberán respetar los tiempos que necesite para realizar las AVD y la prestación de productos de apoyo para facilitar la autonomía.

Así el técnico de apoyo a domicilio:

- Realizará apoyo a las tareas de higiene sólo cuando sea preciso, sí supervisará y ayudará en aquello que se precise, siempre respetando los ritmos de la persona.
- Acompañará en la alimentación proporcionando los apoyos necesarios.
- En las transferencias, movilizaciones y cambios posturales informará siempre al usuario de los movimientos que se vayan a hacer, siendo importante contar con su colaboración.
- En la movilidad asesorará de los productos de apoyo más adecuados.
- Indicará al usuario las adaptaciones domiciliarias más adecuadas a sus características.
- Dará el apoyo físico necesario para que la persona con dependencia pueda desarrollar de la forma más autónoma posible sus actividades de relación social y resolución de gestiones personales y familiares. Por ejemplo le acompañará a trasladarse al Banco para que actualice su cartilla, o hasta el Centro de Mayores para que se reúna con sus amigos.
- Muchos usuarios prefieren que les hagan las tareas, bien porque les cuesta un gran esfuerzo o porque se sienten sin fuerzas, pero es el auxiliar quien tiene que ayudar a modificar esas situaciones y hacer ver al usuario que él es el responsable de su proyecto vital. Tenemos que ver a estas personas desde sus capacidades y no desde sus limitaciones como tantas veces lo hacemos.

1.5. RECURSOS COMUNITARIOS

El auxiliar de apoyo a domicilio debe conocer los distintos recursos existentes en la comunidad para favorecer la plena integración social de la persona dependiente a la que presta sus servicios, así como para satisfacer sus necesidades convivenciales, de ocio, asistenciales y ocupacionales.

Los recursos comunitarios pueden ser públicos (promovidos por las administraciones públicas: ayuntamientos, Diputaciones..) o privados (asociaciones sin ánimo de lucro o entidades privadas).

Los servicios sociales comunitarios, también llamados servicios sociales de base o de atención primaria, están dirigidos a la población en general y son la vía de entrada a los servicios sociales públicos. Ofrecen asesoramiento e información sobre otros recursos y sobre los trámites necesarios para acceder a ellos.

Los servicios sociales especializados tienen funciones preventivas y asistenciales en la atención a determinados sectores de la población.
A continuación se detallan algunos de los servicios y recursos existentes, que el cuidador asistencial debe poner en conocimiento de la persona a la que apoya e incluso acompañarla en las gestiones necesarias para poder acceder a ellos.

RECURSOS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
- Asociaciones
- Centros de información

RECURSOS DE ASISTENCIA
- Residencias para personas mayores
- Residencias para personas con discapacidad
- Viviendas tuteladas
- Centros de día
- Centros de noche
- SAD
- Teleasistencia
- Servicio de comidas a domicilio
- Programas de respiro familiar

RECURSOS PARA EL OCIO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
- Centros u hogares para mayores
- Centros recreativos para personas con discapacidad
- Aulas para mayores
- Programas universitarios para mayores

- Programas de termalismo
- Programas de vacaciones

1.5.1. RECURSOS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

Además de los servicios de base, tenemos que destacar las asociaciones de afectados y familiares. Son entidades sin ánimo de lucro que cuentan con información, documentación y servicios específicos; habitualmente desarrollan actividades de ocio, de cuidado personal, grupos de autoayuda.

1.5.2. RECURSOS DE ASISTENCIA

Son aquellos que ofrecen atención asistencial socio sanitaria a las personas con dependencia para favorecer la permanencia en su propio entorno el mayor tiempo posible en condiciones óptimas recibiendo la atención adecuada. Vamos a comentar brevemente estos servicios:

1.Residencias para mayores

- Ofrecen atención integral, pueden tener carácter temporal (enfermedad, convalecencia, descanso familiar) o permanente.
- Pueden ser públicas o privadas.
- Los requisitos de acceso se establecen en cada comunidad autónoma. Se debe cumplimentar la solicitud de ingreso a la cual se acompaña de informe médico, fotocopia del DNI, empadronamiento, acreditación de ingresos, informe social. Las solicitudes se entregan en las Delegaciones Provinciales de Bienestar Social.

2.Residencias para personas con discapacidad

- Ofrecen atención integral a personas con discapacidad, mayores de edad y menores de 65 años que no pueden vivir de forma independiente. Puede haber de diferentes tipos en función del tipo de discapacidad y grado de afectación.
- Requisitos de acceso: tener al menos un 33% de minusvalía, tener 18 años cumplidos y menos de 65 años, estar empadronado en la comunidad autónoma donde se realiza la solicitud.
- Las solicitudes se presentan en el Servicio social de Base del Ayuntamiento o Delegación autonómica del Bienestar social. En el caso de entidades privadas, el trámite se realizará directamente con la entidad gestora.

3.Viviendas tuteladas

- Son centros de alojamiento para personas que tienen un grado suficiente de autonomía pero que no pueden vivir completamente independientes.
- Requisitos: acreditar la condición de minusvalía, tener entre 18 y 65 años y estar empadronado en la comunidad donde se solicite.
- Entre los documentos a presentar: informe médico, informe social, DNI, acreditación de ingresos, empadronamiento.
- Las solicitudes se presentan en los Servicios Sociales de Base o en las Delegaciones Provinciales del Bienestar Social..

4. Centros de Día

- Son instituciones para mayores o personas con discapacidad que ofrecen atención integral durante el día para favorecer su autonomía personal e integración, la permanencia en su entorno, el retraso en la institucionalización a los casos en situación límite y con grave deterioro físico y/o cognitivo.
- También ofrecen atención a las familias y/o cuidadores proporcionándoles apoyo psicosocial a través de grupos de ayuda.
- Este servicio integral ofrece: servicio de transporte adaptado, atención médica y de enfermería, social, fisioterapéutica, terapia ocupacional, alimentación (desayuno, comida y merienda), higiene personal y dependiendo del centro, atención psicológica.
- Pueden ser públicos o privados.
- Requisitos de acceso: para mayores tener cumplidos 60 años, para personas con discapacidad entre 18 y 65 años, no padecer enfermedad infectocontagiosa, residir en la comunidad autónoma donde se solicita
- Adjuntar acreditación de minusvalía (para personas con discapacidad).
- Informes médico y social, DNI, acreditación de ingresos, certificado de empadronamiento.
- Las solicitudes se presentan en los Servicios Sociales de Base o en las Delegaciones Provinciales del Bienestar Social. Si son privados en la entidad gestora.

5. Centros de Noche

- Son centros para personas con dependencia que necesitan supervisión durante la noche por trastornos en el ciclo del sueño.
- Se puede solicitar información en los Servicios sociales de Base.

6. SAD

- Servicio dirigido a usuarios que necesitan ayuda en la realización de las AVD.
- Ofrecen servicios de atención personal, doméstica y social a tres niveles (preventivo, asistencial y rehabilitador) con el objetivo de mejorar su autonomía y favorecer la permanencia en su domicilio.

- El servicio se realiza en el seno del hogar de la persona o familia que solicita el recurso y apoya a la familia con el fin de evitar internamientos innecesarios.
- Integra las siguientes prestaciones: auxiliar de hogar, lavandería domiciliaria, teleasistencia, camas articuladas, adaptaciones geriátricas, comida a domicilio.
- Se solicita en los Servicios Sociales de Base de los Ayuntamientos
- La solicitud se debe acompañar de fotocopia del DNI, fotocopia del libro de familia, datos de la unidad convivencial, acreditación de ingresos del núcleo familiar, informe médico, certificado de minusvalía.

7. Teleasistencia

- Es un servicio que utiliza las tecnologías de la comunicación para ofrecer atención continuada a la persona con dependencia en su domicilio.
- Realiza funciones de agenda y presta asistencia en caso de emergencia, ayuda a paliar las situaciones de soledad.
- Asegura la intervención inmediata en crisis personales, sociales o médicas para proporcionar seguridad y por tanto, mejor calidad de vida.
- Se solicita en los Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento.
- La solicitud se debe acompañar de fotocopia del DNI, fotocopia del libro de familia, datos de la unidad convivencial, acreditación de ingresos del núcleo familiar, informe médico, certificado de minusvalía.

8. Servicio de comidas a domicilio

- Se dirige a personas en situación de dependencia que tienen dificultades para realizar la compra de alimentos, para preparar comidas y cenas.
- Este servicio suministra comidas ya elaboradas que se pueden consumir en el momento o congelarlas, para luego comerlas cuando lo deseen.
- Puede ser un servicio público o privado.
- La documentación a presentar es la misma que en los servicios anteriores.

9. Programas de respiro familiar

- Están dirigidos a apoyar a los cuidadores o familiares.
- Existen diferentes modalidades, desde unas horas a la semana, hasta fines de semana o momentos puntuales.
- Las personas interesadas pueden informarse en los Servicios Sociales de Base.

1.5.3. RECURSOS DE OCIO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

1. Hogares y clubes

- Están dirigidos a estimular y promover la participación de las personas mayores en la comunidad a través de actividades socioculturales, artísticas, recreativas, etc.
- Con carácter general es necesario ser jubilado o pensionista.
- tener entre 55 y 65 años.
- Solicitud correspondiente.

2. Centros recreativos para personas con discapacidad

- El objetivo es promover la integración de dicho colectivo.
- Son centros promovidos por las asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro.
- Los requisitos de acceso y las cuotas los determina la entidad.

3. Aulas de mayores

- Seminario, programas de actividades de carácter sociocultural para personas mayores.
- Edad de acceso entre 50 y 65 años.
- Solicitud e importe en la entidad que lo organiza.

4. Programas universitarios para mayores

- Pueden tener diferentes nombres según la comunidad autónoma (aulas de la experiencia, universidad permanente....)
- Para mayores de 55 años
- La documentación se presentará en la universidad de referencia. Al formalizar la inscripción se abona una cantidad variable que oscila entre 30 y 75 euros.

5. Programas de Termalismo social

- Proporciona el acceso a los tratamientos que requieren (previa prescripción facultativa) que ofrecen los balnearios a precios reducidos.
- Requisitos: ser pensionista, no padecer enfermedades infectocontagiosas ni trastornos mentales graves, valerse por sí mismo y realizar la solicitud en el plazo indicado, alcanzar una puntuación según baremo.
- Las solicitudes se realizan en los centros de mayores o en las direcciones territoriales del IMSERSO.

6. Programa de Vacaciones

- Facilita el turismo de las personas mayores a precios económicos.
- Requisitos a presentar junto con la solicitud: ser pensionista, no padecer enfermedad infectocontagiosa ni alteraciones de comportamiento que alteren la convivencia en grupo y valerse por sí mismo.

- Las solicitudes se presentan en la web : www.imserso_01/envejecimiento_activo/vacaciones, o en las Delegaciones Provinciales de bienestar Social.

1.6. SOLICITUD DE AYUDAS, PRESTACIONES Y SERVICIOS

La Ley de dependencia supuso la creación del SAAD (Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia), este sistema representa la colaboración de las diferentes administraciones públicas para la organización de todos los recursos públicos y privados con el fin de prestar la atención necesaria a las personas con dependencia.

Los usuarios del SAAD serán los beneficiarios de la Ley de dependencia y deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.
- Para menores de 3 años , disposición adicional decimotercera.
- Residir en territorio español y haberlo hecho durante 5 años, dos de los cuales serán anteriores a la presentación de la solicitud. Para los menores de 5 años el periodo de residencia se exigirá a quien ejerza su guarda y custodia.

Para solicitar y acceder a las ayudas, prestaciones y servicios del SAAD, es necesario obtener el reconocimiento de persona en situación de dependencia, para ello hay que pasar una valoración del órgano gestor de la Comunidad Autónoma (en el caso del País Vasco: las Diputaciones Forales). Los documentos necesarios: Fotocopia del DNI, certificado de empadronamiento, acreditación de residencia durante 5 años, e informes médicos.

La Ley de dependencia establece los siguientes grados.

GRADO I. Niveles 1 y 2 Dependencia moderada	La persona necesita ayuda para realizar varias AVD al menos 1 vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal
GRADO II Niveles 1 y 2 Dependencia severa	La persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria 2 ó 3 veces al día, no requiere apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal

GRADO III Niveles 1 y 2 Gran Dependencia	Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias ABVD varias veces al día, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita apoyo continuado de otra persona y tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal

El catálogo de servicios para la atención a la dependencia que ofrece la ley es el siguiente (artículo 15 de la LEY)

1. Prevención de las situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal: programas de prevención, rehabilitación y entrenamiento en autonomía personal.
2. Teleasistencia: facilita ofrecer respuesta inmediata a situaciones de emergencia, puede compatibilizarse con el de ayuda a domicilio.
3. Ayuda a domicilio: Actuaciones dirigidas a prestar apoyo en las AVD en los propios domicilios, incluyen cuidados personales y de las necesidades del hogar.
4. Centros de día y Centros de Noche: servicio de atención integral cuyo objetivo es la mejora y mantenimiento de la autonomía de las personas con dependencia, así como servir de apoyo a las familias y cuidadores. La ley de la dependencia distingue entre: centros de día para menores de 65 años, centros de día de atención especializada y centros de noche.
5. Atención residencial: ofrecen atención integral continuada. Puede ser temporal o permanente. Según la Ley se distinguen entre residencias para personas mayores en situación de dependencia y centros de atención a personas en situación de dependencia (enfermedades mentales y discapacidades).
6. Prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de un servicio de atención: tendrán un carácter periódico y se concederán solo en el caso de no poder atender a la persona en un servicio público o concertado, se tiene en cuenta el grado de dependencia y la capacidad económica del usuario.
7. Prestaciones económicas para cuidadores no formales o cuidados en el entorno familiar: se tendrá en cuenta que la vivienda reúna las condiciones necesarias de habitabilidad y salubridad. Los cuidadores deben reunir unos requisitos de afiliación, alta y cotización a la seguridad social
8. Prestaciones económicas de asistencia personal: dirigidas a la contratación de asistencia personal que facilite el acceso al mundo laboral y educacional de las personas con dependencia de grado III, así como lograr una mayor autonomía en la realización de las AVD.

La cuantía máxima de estas prestaciones se fija anualmente y para ello se tiene en cuenta la capacidad económica del usuario. (Real decreto 374/2010)

Es conveniente que el profesional conozca la Ley de dependencia, así como las prestaciones, ayudas y servicios para poder asesorar a los usuarios sobre la oferta que mejor se adapte a sus necesidades.

2. INTERVENCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA RELACIÓN SOCIAL, EN LA RESOLUCIÓN DE GESTIONES Y EN EL ENTORNO FAMILIAR

2.1 FUNCIONES Y PAPEL DEL PROFESIONAL DE ATENCIÓN DIRECTA DESDE LA UNIDAD CONVIVENCIAL. ÁREAS DE INTERVENCIÓN.

Las funciones del profesional de atención directa deben satisfacer aquellas necesidades que la persona en situación de dependencia no pueda cubrir o satisfacer por sí misma.

El objetivo de la ayuda en el domicilio es mantener al usuario el máximo tiempo posible y con la mejor calidad de vida en su núcleo convivencial. Es un servicio concebido con una doble función: **prevenir** y/o **rehabilitar.**
Prevenir situaciones de riesgo fomentando hábitos saludables de higiene, alimentación, sueño, evitar el consumo de sustancias tóxicas, eliminar barreras que puedan provocar una caída o un accidente doméstico, crear un entorno de vida saludable, favorecer el contacto social y con el entorno respetando la intimidad sin dejar que la persona se aísle...

Y **rehabilitar**, mantener y/o estimular habilidades y capacidades limitadas, para lo que se intenta promover la autonomía de la persona y su independencia mediante el entrenamiento en actividades de la vida diaria: vestirse, comer, asearse, andar, hacer gestiones, ...

Para lograrlo, el profesional de ayuda deberá desempeñar las siguientes **funciones**:

- **Apoyo doméstico**: apoyar al usuario en el cuidado del domicilio realizando actividades domésticas y en la resolución de gestiones del entorno familiar.
- **Apoyo personal**: atender a las necesidades del usuario respecto a la alimentación, higiene y autocuidado, deambulación.
- **Apoyo psicosocial**: dirigido a mantener y mejorar sus posibilidades comunicativas y relacionales, su participación social así como promover sus habilidades de gestión. Es importante el refuerzo familiar: el auxiliar debe fomentar la colaboración y cohesión familiar (y nunca intentar

sustituirla) así como prestar especial interés en el cuidador principal para prevenir situaciones de estrés y sobrecarga por el cuidado diario.

2.1.1. FUNCIONES DEL PROFESIONAL DE ATENCIÓN DIRECTA:

1. Apoyar: ayudar al usuario a activar sus propios recursos psicológicos y emocionales (supone escuchar, entender, hacerle sentirse seguro).

2. Motivar: estimular para que el usuario tome, sea responsable de su proyecto vital. Animar a realizar las tareas que aún pueda.

3. Supervisar: comprobar que las tareas se realizan de manera adecuada sin suponer un riesgo para la seguridad de la persona. Observar las AVD para la posterior puesta en común con el equipo del SAD.

Es por todo esto importante diferenciar la figura del profesional de atención directa de la persona que puede acudir al domicilio a realizar labores domésticas. Como puede verse, el auxiliar se encuentra preparado y formado para desempeñar otro tipo de funciones.

Para orientar adecuadamente el profesional deberá:

- Obtener la información oportuna respecto a las capacidades, limitaciones y necesidades de la persona con dependencia.
- Coordinarse con otros miembros del equipo (trabajador social, equipo del SAD) para compartir información sobre la evolución del usuario y establecer criterios comunes de intervención.
- Tener en cuenta las orientaciones del profesional competente (terapeuta ocupacional, médico, trabajador social...) en cuanto al apoyo necesario para realizar las AVD.

2.1.2. ÁREAS DE INTERVENCIÓN

Respecto a las ÁREAS de intervención, tanto el acompañamiento como el apoyo social en el domicilio parten de una atención integral a la persona, por lo tanto se deberá atender a las siguientes áreas:

a) Área psicoemocional:

Los usuarios pueden encontrarse en situación de fragilidad emocional, puesto que el hecho de necesitar ayuda de terceras personas en su hogar puede repercutir en su autoestima. Además supone aceptar la entrada de una persona extraña en su espacio más personal, lo cual se percibe como una pérdida de intimidad y de autonomía. Debemos escuchar, y apoyar la expresión de sentimientos sin censurarlos, manifestando afecto y respeto a la persona con dependencia.

Intervenciones:

- Facilitar y respetar la expresión de los sentimientos de la persona con dependencia. El profesional deberá comprender las emociones del usuario e intentará ayudar a expresarlas.
- Apoyar la expresión de los sentimientos de los familiares de la unidad convivencial.
- Demostrar aprecio y aceptación hacia el usuario con el fin de favorecer un clima de confianza y seguridad.

b) Área informacional:

Buscar y dar información sobre los recursos existentes y la forma de acceder a ellos, intentando favorecer la relación del usuario y el familiar con el entorno.

Intervenciones:

- Transmitir información actualizada de las actividades de su entorno (actividades organizadas, gerontogimnasia, dibujo, ferias, festividades,...)
- Informar sobre los recursos socioeconómicos (subvenciones que pueden solicitarse, ayudas...)
- Informar a la familia sobre recursos de apoyo a cuidadores y familiares (asociaciones, grupos de apoyo, programas de respiro..)

c) Área asistencial :

Después de analizar la funcionalidad del usuario ayudaremos a realizar aquellas tareas en las que sea necesario intervenir (siempre dejando hacer y respetando tiempos).

Intervenciones:

- Cuidar la imagen personal del usuario, servir de apoyo en la higiene respetando el ritmo de cada uno.
- Servir de apoyo en la alimentación. Motivar al usuario a manifestar sus gustos por los diferentes platos.
- Apoyar en las transferencias y cambios posturales, facilitando los apoyos necesarios para que el usuario pueda colaborar de forma activa (agarrarse, estirarse, apoyarse...) informándole siempre sobre el tipo de movimientos que se le van a realizar y de qué manera.
- Ayudar a la movilidad de la persona. Eliminación de barreras arquitectónicas que impidan la movilidad y facilitar los apoyos técnicas necesarios (bastón, andador...)
- Apoyar en la realización de las tareas domésticas diarias: cuidado de la ropa, limpieza del hogar y en aquellas que pueden suponer un riesgo para la persona con dependencia (limpieza de zonas altas...)

- Recordar la toma de medicación y en caso necesario prepararlas y administrarlas siguiendo las prescripciones médicas.

d) Área de Ocio y tiempo Libre:

Deberemos mostrar las posibilidades que ofrecen las actividades lúdicas para su autorrealización y autonomía personal.

Intervenciones:

- Facilitar los apoyos para que pueda facilitar de forma autónoma sus aficiones.
- Informar sobre las actividades que se ofertan en su entorno y animar a que participe en aquellas que sean de su agrado.
- Facilitar la asistencia de la persona con dependencia a actividades del entorno y de su interés (actividades deportivas, religiosas, recreativas..) y si fuera preciso acompañarlo.

e) Área de relaciones sociales y de comunicación:

Trataremos de conservar y favorecer las relaciones comunicativas y las redes sociales del usuario.

Intervenciones:

- Incentivar el contacto con familiares, amigos, vecinos a través del teléfono, correo postal o electrónico.
- Fomentar los contactos con familiares o amigos ayudando a generar las condiciones adecuadas para que se den en el propio domicilio del usuario. Y acompañar al lugar del exterior señalado para establecer el contacto.
- Favorecer la realización de actividades como ir a la peluquería, al centro de mayores, a las compras (tanto de alimentos, como de ropa y otros artículos)

f) Área educativa :

Utilizaremos técnicas de modificación de conducta (tema 4 de esta unidad formativa) para enseñar y practicar hábitos de autonomía personal y social correctos.

Intervenciones:

- Aplicar técnicas de modificación de conducta para reforzar comportamientos ya existentes, introducir conductas nuevas y eliminar las no deseadas.
- Servir de apoyo en la resolución de conflictos.

g) Área de gestión:

Todas aquellas gestiones de administración y organización de la documentación personal doméstica (ayudar a revisar y archivar facturas del gas, luz, teléfono.

Intervenciones:

- Registrar, ordenar y mantener la documentación médica del asistido, solicitando citas, recogiendo recetas.
- Realizar gestiones bancarias como actualizar la libreta, sacar dinero para los gastos cotidianos, acompañar al usuario para realizar otros trámites bancarios.
- Informar sobre la documentación necesaria y los trámites para solicitar ayudas, recursos y servicios de los que pueda beneficiarse.
- Cumplimentar solicitudes de ayuda.
- Ayudar a interpretar la documentación bancaria (facturas..) y sanitaria.
- Ayudar a la gestión financiera del hogar: recoger y ordenar facturas, tiques de compra, gastos e ingresos del mes...
- Llevar a cabo funciones de agenda, recordar citas, apuntarlas en calendarios o agendas...

No debemos olvidar la importancia de **IMPLICAR AL USUARIO** en la realización de todas estas tareas en la medida que sea posible, con el fin de aumentar su bienestar personal.

2.2. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN LÍMITES Y DEONTOLOGÍA

El auxiliar de apoyo domiciliario debe realizar sus intervenciones utilizando las siguientes estrategias de actuación:

- Establecer vínculos relacionales con el asistido: trabajar mostrando empatía, la escucha activa y la asertividad. Para trabajar desde el acompañamiento es necesario que exista una relación de confianza con el usuario.

- Reforzar positivamente cualquier avance: es importante observar y valorar cualquier esfuerzo que el usuario realice, aunque el logro sea pequeño. Debemos huir de los reproches por aquello que no realiza o que no lo hace de forma correcta.

- Plantear intervenciones de forma progresiva: es decir, planificar tareas de menos complicadas a más complejas. Planteando siempre metas que se puedan alcanzar, cualquier avance, aunque pequeño, es mejor que ninguno; así conseguiremos reforzar su autoestima.

- Hacer sentir al usuario protagonista de su proceso y de sus decisiones: el usuario no tiene por qué padecer las decisiones de otros, debe de ser capaz de tomar sus decisiones, de ser responsable de cómo quiere ser cuidado y como cuidarse, de qué hacer.

- Mantener una actitud tranquila y serena que favorezca el equilibrio para enfrentarse de la mejor manera a las situaciones conflictivas.

- Ser responsable de su profesión, ser puntual y correcto.

- Respetar la intimidad de la persona, evitar criticar actitudes aunque no se compartan.

- Respetar el secreto profesional sin desvelar nunca datos de la persona en situación de dependencia ni de sus familiares.

- Delicadeza y discreción a la hora de introducir cambios en el hogar, empezando por modificaciones pequeñas que se irán introduciendo de manera paulatina y gradual.

- Actuar como elemento integrador entre la familia y el usuario, favoreciendo la comunicación y la colaboración entre ellos.

2.3. INTERVENCIONES MÁS FRECUENTES. GESTIONES. SEGUIMIENTO

Las intervenciones del auxiliar de apoyo domiciliario más frecuentes son las siguientes:

- **Intervención de tipo educativo: enseñar.**

En las intervenciones de apoyo, resulta mucho más provechoso involucrar a las personas en su propia asistencia. Cuando se pretende ayudar a alguien, lo correcto no es darle las cosas hechas sino enseñarle a realizarlas por sí mismo. Así se consigue gran motivación y se evita dañar negativamente su autoestima. Las personas en situación de dependencia dejan de verse como sujetos pasivos, inferiores, infravalorados para sentirse personas con valor, objetivos y metas. Es por ello que se debe intentar que estas personas continúen realizando aquellas actividades que sean capaces de realizar por sí mismas, aunque sean lentos o no la lleven acabo perfectamente. Si no fueran capaces de realizarla de forma global, se les debe dejar que lleven a cabo los pasos que aún puedan ejecutar con la mínima ayuda posible.

- **Intervención en materia de prevención, mantenimiento, rehabilitación.**

El auxiliar domiciliario debe estar atento y observar los cambios y actitudes de la persona dependiente para prevenir y evitar consecuencias negativas aumentando así la calidad de vida. Para ello es conveniente que:

- Inculque hábitos saludables: informar para evitar el consumo de hábitos tóxicos, asesorar sobre la realización constante de ejercicio físico, alimentación variada, higiene diaria, hidratación, cuidado de la piel, etc.

- Oriente para actuar de forma adecuada ante una enfermedad o discapacidad: informar de pautas adecuadas de salud, asesorar sobre los distintos profesionales de la salud dependiendo de las necesidades de cada persona, proporcionar direcciones de centros de mayores cercanos, ...

- Asesorar e informar sobre las actividades y acontecimientos que se desarrollen en su entorno: acontecimientos culturales y de ocio accesibles, teniendo en cuenta los gustos, ideas y valores de la persona.

- Favorecer y fomentar las relaciones sociales y afectivas: Estimular a la persona para que inicie y mantenga relaciones con la familia, amigos, vecinos,...; animar a escribir cartas o llamar por teléfono, así como dialogar con la familia y mantenerla informada de la evolución y estado de la persona.

- **Intervención en situaciones de emergencia**

Es necesario que el profesional esté preparado para actuar lo más rápidamente posible y sin bloquearse en este tipo de situaciones:

- Accidentes domésticos (caídas, intoxicaciones, quemaduras, cortes, etc.) Cuando sea de gravedad, es preferible llamar al servicio de emergencia (112) y avisar después a la familia, cuando la situación esté ya controlada. Es conveniente dominar las técnicas de primeros auxilios y de reanimación cardiopulmonar por si fueran necesarias.

- Accidentes relacionados con el equipo sanitario (sondas que se sueltan...) o enfermedad que se complica. En este caso conviene avisar al serviio de salud y al coordinador del servicio.

Deberá ponerse en contacto con personal sanitario y/o con el coordinador del servicio ante cualquier situación en la que no sepa cómo actuar.

- **Intervenciones técnicas y adaptativas en el domicilio**

Eliminación de barreras arquitectónicas y acondicionamiento de la vivienda a las necesidades de la persona dependiente, productos de apoyo, etc, detectar nuevas necesidades, supervisar el estado y uso de equipos, apoyos técnicos, etc.

2.4. DOCUMENTACIÓN PERSONAL Y DE LA UNIDAD CONVIVENCIAL.

El auxiliar de ayuda a domicilio puede que tenga que manejar documentos personales y por ello es necesario que citemos brevemente la documentación que tendrá que conocer y manejar.

- **Documentación personal básica del asistido,**

Destacan los siguientes documentos:

- **DNI:** documento que acredita la identidad de la persona, los extranjeros con permiso de residencia tienen NIE (Número de Identificación de Extranjeros).
- **Certificado de nacimiento**: emitido por el Registro Civil da fe de la fecha y lugar de nacimiento de la persona.
- **Permiso de conducir.**
- **Tarjeta sanitaria**: que permite acceder a los servicios sanitarios públicos. En el aparece el médico de referencia y el centro de salud
- **Otras tarjetas sanitarias o acreditación de seguros sanitarios privados.**
- **Cartilla de vacunación** (es poco habitual en los adultos, pero algunos mayores se vacunan para protegerse de diferentes riesgos. Alergias, gripe.. por lo que es necesario que el auxiliar los conozca.
- **Historia clínica**: recoge todas las incidencias relacionadas con el estado de salud de la persona, no es habitual que esté en el domicilio del usuario.
- **Informes médicos.**
- **Reconocimiento de grado y nivel de dependencia y PIA.**
- **Recetas médicas.**
- **Seguros de vida y accidentes.**
- **Cartilla del banco**: Es preciso que los familiares y el usuario tengan localizadas las tarjetas de crédito y limitar su uso con el fin de evitar que las personas con demencia realicen gastos equivocados. Es necesario que haya un segundo titular en la cuenta para que pueda realizar las gestiones en caso de enfermedad o empeoramiento. Está desaconsejado que sea el auxiliar.
- **Declaración de la renta.**
- **Certificado de pensiones.**

- **Planes de pensiones o de jubilación.**

- **Documentación de la unidad convivencial:**

- **Escrituras de la vivienda o contrato de alquiler** puede ser necesario tener localizados estos documentos para solicitar ayudas para realizar adaptaciones en el domicilio.
- **Contratos de suministros:** electricidad, agua, teléfono, Internet..
- **Seguro del hogar.**
- **Facturas** (para en el caso de reparación de electrodomésticos..)
- **Justificantes bancarios.**

Es muy importante que el auxiliar mantenga **la confidencialidad** en el manejo de la documentación tanto del usuario como de la unidad convivencial. El profesional tiene acceso a la información que aparecen en los documentos para desempeñar su trabajo y poder realizar las labores asignadas, para prestar ayuda a la persona con dependencia en las gestiones y trámites determinados. Por ello es básico que tenga siempre una actitud discreta y guarde cuidadosamente toda la documentación.

La confidencialidad forma parte del código ético del profesional de ayuda a domicilio y supone que no debe difundir la información obtenida en el desempeño de su profesión, tanto la referida a los datos personales, como a la salud.

En resumen, las intervenciones del auxiliar han de respetar siempre los derechos de las personas implicadas en la asistencia domiciliaria, manteniendo las indicaciones de la ética profesional.

2.5. TÉCNICAS BÁSICAS DE ELABORACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE DOCUMENTACIÓN

Las técnicas de elaboración de documentación deben permitir generar un documento útil para la atención personal del usuario y la gestión del hogar, estas técnicas deben permitir localizar con facilidad todo tipo de documentación e información que se requiera.

Instrumentos que pueden ser útiles para elaborar la documentación:

Libreta o cuaderno: donde se irán apuntando los gastos e ingresos del mes para controlar la economía de la unidad convivencial. Registraremos la alimentación (tipos de alimentos ingeridos, dietas..)

Carpetas: nos ayudan a tener ordenados y localizados los documentos. Podemos colocar los informes médicos en una, los contratos de suministros, seguros en otra, las garantías de los electrodomésticos e instrucciones de uso en otra; las facturas en otra, las declaraciones de la renta, certificados de pensiones en otra. Estas carpetas las señalizaremos de forma clara, incluso podemos utilizar diferentes colores para localizarlas.

Utilizar una bandeja para colocar la documentación pendiente de archivar, (una vez al mes se podrá revisar y archivar) también suele ser de utilidad.

La documentación generada años anteriores y que por lo tanto no necesita estar tan accesible se podrá guardar en cajas.

Suele ser útil un pequeño tablón de anuncios donde colocar la documentación que ha de estar más presente, por ejemplo citas médicas, recetas pendientes de recoger, números de teléfono que se usan con más frecuencia, cupones de descuento del supermercado…Posteriormente se archivará esta información.

La documentación personal del usuario (DNI, tarjeta sanitaria, etc.) es aconsejable que la lleve la persona asistida, de esta forma ayudaremos a normalizar su situación. En el caso de que no pueda salir solo del domicilio, esta documentación se podrá guardar con el resto en un lugar específico y accesible.

2.6. CONFIDENCIALIDAD A LA HORA DE MANEJAR LA DOCUMENTACIÓN DE OTRAS PERSONAS

Podemos definir la **confidencialidad** en el ámbito de la atención domiciliaria como el derecho del usuario al respeto de la privacidad de todos los datos relacionados con su persona por parte de los profesionales, incluyendo los datos e información de carácter sanitario.

Es un deber moral cuyo valor deriva de los fines a los que sirve seguridad, respeto,…El profesional de atención domiciliaria tiene obligaciones de confidencialidad mayores al velar por la dignidad y la autonomía del usuario, que suponen la obligación de guardar reserva sobre la privacidad e intimidad de los datos personales referidos a la salud.

Además de la confidencialidad, el auxiliar debe mostrar **respeto por la intimidad** de las personas dependientes, (visto ya en la unidad formativa 119, punto 2.7.) esto es, el derecho de las mismas a mantener sus vidas, sus actos y sus circunstancias personales fuera de la "vista de los demás". En este sentido, caben destacar algunas pautas de actuación:

- Comentar los aspectos referentes al estado o evolución de los enfermos en voz baja.

- Nadie más que el usuario debe saber si está enfermo o si se le debe practicar determinado cuidado. Se evitará exponer o mostrar listados de usuarios, datos médicos, evolución de su estado...
- Abstenerse de hacer comentarios frívolos (con otro/as auxiliares...) sobre cualquier circunstancia de salud o personal tanto del usuario como de su familia.
- La información personal del usuario no deberá usarse para fines distintos de los asistenciales.
- Todo documento en el que aparezca el nombre de un usuario deberá sustraerse del alcance de personas ajenas al ámbito asistencial.
- No se permitirán filmaciones o fotografías en las que se pueda identificar a los usuarios sin su autorización expresa o la de la familia en caso de incapacidad.
- Sólo las personas autorizadas podrán acceder a las aplicaciones informáticas que recojan datos del usuario, utilizando su clave de acceso, personal e intransferible.
- En el transcurso del aseo o cura de un usuario se respetará al máximo su legítimo pudor a mostrar la desnudez o las partes más íntimas de su cuerpo.
- El profesional de apoyo domiciliario, en el ejercicio de sus funciones, invade con frecuencia la "esfera personal" o zona íntima de los usuarios, por lo que se hace necesario ser extremadamente cuidadoso y respetuoso a la hora de realizar las técnicas y los cuidados, informando en cada momento de qué se va a hacer, cómo, durante cuánto tiempo y para qué.

2.7. RESPETO DE LOS LÍMITES DE ACTUACIÓN Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL

2.7.1. LÍMITES

El auxiliar de apoyo domiciliario debe establecer unos LÍMITES en su actuación necesarios para que en una relación ninguna de las personas implicadas salga dañada y para evitar agravar la dependencia del usuario. El trabajo en domicilio es complejo porque supone una relación de ayuda en la vivienda de la persona asistida. Supone el encuentro entre personas con características, valores, preferencias, miedos y opiniones diferentes que a menudo planteen dudas sobre "¿cómo reaccionar ante este comentario?" "¿ Hasta que punto debo que implicarme en una situación?". Por ello los Límites de actuación deben estar muy presentes. El profesional:

- Tiene que evitar aumentar la dependencia, a veces se cae en la tentación de ayudar más de lo que las personas necesitan. Es algo que hace sentir bien y que el usuario suele agradecer, pero en vez de fomentar sus posibilidades, aumentamos su dependencia.

- Evitar vivir la vida de la persona con dependencia, hacer propios los problemas del usuario, no sólo no ayuda, sino que pone en riesgo la propia estabilidad emocional del profesional.

- La manipulación: puede darse por las dos partes, por un lado el profesional piensa que sabe lo que es lo mejor y trata a toda costa de dirigir al usuario. Y por parte del usuario que pretende que el profesional realice determinadas tareas que él mismo puede realizar.

- Evitar las situaciones de abuso físico, es importante no sobrepasar las barreras de la relación profesional y aprovechar la situación de la persona para realizar otro tipo de contactos.

- Evitar el aislamiento, y una situación de excesiva dependencia relacional con el profesional. Por ello es fundamental apoyar los vínculos con las personas del entorno motivándoles a salir a pasear, a mantener el contacto con vecinos y amigos, a realizar actividades con otras personas.

- Evitar tomar partido tanto por el usuario como por algún familiar o miembro de la unidad convivencial. El profesional no debe juzgar las relaciones personales del usuario con su familia. (La mayoría de las veces tenemos una información parcial de lo que sucede, de la historia familiar, por lo que el profesional debe ser prudente en el caso de que le pidan su opinión).

El auxiliar no es un amigo o un familiar del usuario aunque en ocasiones sea la persona que más contacto mantiene con la persona con dependencia. El auxiliar es un profesional y su objetivo debe ser desarrollar su trabajo de la mejor manera posible, empatizando con la persona pero sin dejarse arrastrar por la situación de la persona con dependencia.

Se trata de mantener un equilibrio pues no respetar los límites profesionales conlleva unos riesgos, entre los que destacamos:

- **Aumento de las exigencias profesionales y personales**. Una incorrecta interpretación de la asistencia e implicación con el usuario puede contribuir a aumentar su dependencia, en lugar de ayudarle a mantener su autonomía. El auxiliar se convierte en imprescindible para el asistido. Esta actitud no solo **aumenta la dependencia** funcional del usuario, sino también las exigencias profesionales, cada vez espera más del auxiliar, cada vez espera mayor disponibilidad, que a veces puede exceder al ámbito profesional.

- **Conflictos por mal desempeño profesional**. Detalles aparentemente inocentes (como recibir un regalo o una invitación a

tomar un café) pueden ser reprochados en un momento concreto. Estos conflictos son innecesarios si el profesional no sobrepasa sus límites profesionales.

- **Sufrimiento emocional**: el auxiliar siempre tiene que tener presente que habrá aspectos que escapen a sus posibilidades de actuación. Algunos ejemplos: que el usuario precise más horas de servicio, pero que no se le han concedido, las relaciones conflictivas entre el usuario y su familia, el hecho de que una enfermedad conlleve un deterioro irreversible y progresivo.

2.7.2. PRINCIPIOS DEONTOLÓGICOS BÁSICOS

La DEONTOLOGÍA hace referencia a los principios y reglas éticas que regulan y orientan una actividad profesional. En el caso del trabajo diario del auxiliar domiciliario, caben destacar dos aspectos fundamentales que lo hacen especialmente necesitado de guiarse por unos principios éticos sólidos: Por un lado, trata con personas en situación de vulnerabilidad, por lo que su objetivo último será el respeto a la dignidad de la persona. Y por otro lado, se trata de un trabajo que se realiza fundamentalmente en el domicilio del usuario, lo que le otorga características muy especiales.

Los principios deontológicos que deben orientar la práctica profesional de la asistencia domiciliaria son:

- **Principio de Bienestar**: el profesional es el responsable de prestar la mejor atención posible a todos y cada uno de los usuarios, sin discriminaciones de edad, discapacidad, sexo, raza , clase social, religión, lengua, creencias políticas, inclinación sexual. Poniendo todos sus conocimientos y actitudes personales al servicio del ejercicio de la profesión.
- **Principio de individualidad**: cada usuario es único y diferente, tendremos que tratarlo como tal y no como a uno más.
- **Principio de aceptación y respeto**: aceptar a la persona tal y como es, sin prejuicios, sin juzgar.
- **Principio de autodeterminación**: el usuario tiene derecho a elegir y a actuar conforme a su proyecto de vida.
- **Principio de secreto profesional**: Este principio implica respetar la confidencialidad de los datos del usuario.
- **Principio de profesionalidad**: el auxiliar tiene que esforzarse por ampliar sus conocimientos y mantenerse actualizado en las técnicas y habilidades de atención propias de la profesión.
- **Deber ser puntual**: la falta de puntualidad afecta a la organización del tiempo y las tareas de cada usuario. Hay que tener en cuenta que muchas personas la visita del auxiliar es la única que reciben al día o a la

semana. Restarle importancia a este aspecto es faltarle al respeto al usuario.

- **Presentar una imagen aseada y pulcra,** utilizando un vestuario de trabajo adecuado, mantenerlo limpio y en buenas condiciones, utilizando guantes cuando sea necesario.
- **No fumar en el domicilio**: independientemente de que el usuario lo haga o no.
- **No comer ni beber en el domicilio del asistido**: no sólo resta tiempo de trabajo, sino que puede generar situaciones de deuda o conflicto . No se debe tampoco llevar comida o bebida propia.
- **Evitar pedir favores o aceptar regalos,** pueden igualmente generar sensación de deuda.
- **Mantener informada a la empresa o entidad contratante de las incidencias que puedan afectar al trabajo** (bajas por enfermedad, citas médicas...)

Conclusión: es fundamental que el auxiliar de ayuda a domicilio conozca y respete el código deontológico y los límites que no debe sobrepasar en su relación con las personas, con el objetivo de poder realizar su trabajo de una forma eficaz y contribuir al bienestar de las personas con dependencia.

3. AYUDAS TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA LA VIDA COTIDIANA

Todas las personas utilizamos diferentes utensilios y herramientas que nos facilitan la realización de las tareas, las personas con discapacidad y/o con dependencia necesitan más apoyos para realizar de forma autónoma las AVD. A estos utensilios de ayuda, se les denomina " PRODUCTOS DE APOYO" (antes " ayudas técnicas").

Los productos de apoyo (según la Norma UNE-EN-ISO 999: 2007) son cualquier producto (dispositivos, equipos, instrumentos, tecnología y software) fabricado especialmente o disponible en el mercado para prevenir, compensar, controlar, mitigar o neutralizar deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación.

Es responsabilidad del terapeuta ocupacional la valoración, el diseño, la adaptación y el entrenamiento de los productos de apoyo. Y es labor del auxiliar:

- La recogida de la información relevante del domicilio y del entorno inmediato.
- Identificación de obstáculos y barreras arquitectónicas

- Eliminación de aquellos objetos que puedan suponer una situación de riesgo para el usuario.
- Incremento de la autoestima y motivación del usuario, al posibilitar un mayor grado de independencia en su entorno.
- Consejo al cuidador principal sobre posibles adaptaciones para mejorar la calidad de vida del usuario, junto con el trabajador social responsable del caso y el terapeuta ocupacional.

A veces las personas con dependencia dejan de realizar diferentes tareas porque desconocen las posibilidades que pueden ofrecerles los productos de apoyo y en muchos casos facilitándoles estos productos pueden desenvolverse de una forma más autónoma en sus AVD. Deben ser personalizados, desde un enfoque integral, (que englobe las áreas física, cognitiva, funcional y social) observando las capacidades y limitaciones de las personas en cada una de ellas.

Algunos de estos productos son muy sencillos, por ejemplo un dispositivo para triturar las pastillas y así facilitar la ingesta. Otros, por el contrario, necesitan de una valoración de las características y necesidades de la persona por parte de personal autorizado (Servicio Foral GIZATEK en Bizkaia,) quienes seleccionaran el producto que mejor se adecue al usuario y le ayudarán a entrenarle en su uso en caso necesario.

A la hora de **seleccionar los productos de apoyo** seguiremos los siguientes **criterios** :

- Necesidad: cuando se detecte una necesidad por parte del usuario y del profesional.
- Sencillez y normalización: priorizaremos productos de apoyo cómodos y lo más naturales posibles, lo que aumentará la aceptación del producto. Deben ser también de fácil mantenimiento.
- Adaptación al usuario: deben adaptarse a las características del usuario, y no al revés, a veces será necesario modificar el producto.
- Calidad- precio: es importante que el producto sea duradero, y que el precio sea ajustado. (Existen subvenciones por parte de las administraciones públicas).
- Seguridad: Deben ser retirados todos los obstáculos que supongan riesgo.
- Progresivo: No se deben introducir todos los cambios de forma brusca.

Los productos se pueden comprar directamente en el comercio elegido o a través de subvenciones de las administraciones públicas (siempre que haya un reconocimiento de Discapacidad y/o de Dependencia). (Servicio Gizatek en Bizkaia).

A nivel estatal existe un centro que depende del IMSERSO CEAPAT Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (Orden ministerial de 7 de Abril de 1989).
Este centro tiene como misión contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, con especial apoyo a personas con discapacidad y personas mayores, a través de la accesibilidad universal, el diseño para todos y la tecnología de apoyo).

El CEAPAT ha confeccionado un catálogo que recoge información sobre todos los productos de apoyo que se comercializan y se distribuyen en España, incluye las entidades que los realizan con el fin de proporcionar una herramienta de consulta práctica para las personas que en un momento determinado precisen un ayuda de este tipo.
La clasificación de los productos de apoyo (siguiendo la norma ISO 9999:2007) es la siguiente:

04 Productos de apoyo para tratamiento médico personalizado
05 Productos de apoyo para el entrenamiento/aprendizaje de capacidades
06 Ortesis y Prótesis
09 Productos de apoyo para el cuidado y protección personal
12 Productos de apoyo para la movilidad personal
15 Productos de apoyo para las actividades domésticas
18 Mobiliario y adaptaciones para viviendas y otros inmuebles
22 Productos de apoyo para la comunicación
24 Productos de apoyo para la manipulación de objetos y dispositivos
27 Productos de apoyo para mejorar el ambiente, herramientas y maquinaria
30 Productos de apoyo para el esparcimiento

Puesto que cada usuario es único y que cada enfermedad no se manifiesta igual en dos personas, es necesario partir de un conocimiento profundo de cada persona, de su unidad familiar y del entorno que le rodea para lograr un mejor rendimiento de los productos de apoyo.

3.1. PRODUCTOS DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES DOMÉSTICAS

Estos productos van dirigidos a mantener/mejorar la independencia en la realización de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Se diferencian en función de las tareas que facilitan.:

- Productos de apoyo **para preparar comida y bebida**: encontramos productos para pesar, medir, cortar, picar, dividir, limpiar, pelar, freír, hornear, así como máquinas para preparar la comida y otros electrodomésticos (hornos, frigoríficos..)

- Productos de apoyo **para lavar la vajilla** se incluyen fregaderos, cepillos, estropajos, escurridores de platos, filtros de salida y tuberías, lavavajillas.
- Productos de apoyo **para comer y beber**: tapones, embudos, dispensadores de comida, cubiertos, vasos, tazas, platos, topes y bordes elevados para platos, así como aparatos para dar de comer y las sondas alimentarias.
- Productos de apoyo **para la limpieza del hogar**: cepillos, recogedores, esponjas, fregonas, cubos, aspiradoras, limpia alfombras, enceradoras, abrillantadores, dispositivos para almacenar desperdicios.
- Productos de apoyo **para confeccionar y mantener textiles:** agujas de coser, de punto, máquinas de coser, bastidores, planchas, tablas de planchar, escurridores de ropa, cestos, tendedores, pinzas para la ropa, útiles para la limpieza del calzado.

3.2. MOBILIARIO Y ADAPTACIONES PARA VIVIENDAS Y OTROS INMUEBLES

Es importante que el hogar de la persona asistida cuente con las adaptaciones que faciliten su movilidad y autonomía. El domicilio suele ser el lugar donde la persona con dependencia pasa el mayor número de horas, por ello es importante que la persona se sienta cómoda.

El catálogo del CEAPAT en este apartado recoge las siguientes subcategorías:

a) **Mesas**: de trabajo, de lectura, de dibujo, de cama, de comedor, regulables, escritorios, y soportes para la lectura.
b) Equipos **para la iluminación:** productos relacionados con las luces generales, de lectura y trabajo.
c) **Mobiliario para sentarse**: sillas, sofás, sillones de descanso, muebles especiales para sentarse, reposabrazos, reposapiernas y reposapiés, respaldos, sistemas de sujeción, almohadillas y cojines.
d) **Camas**: en este apartado se incluyen además los productos para transferencia , giro y elevación. Ropa de cama, colchones, somieres, mantas con posibilidad de ajuste, barandillas, barras para ayudar a levantarse por sí mismo, elementos para reducir el tamaño de la cama.
e) **Productos para ajustar la altura del mobiliario**: extensores de patas, pedestales, repisas de altura fija o ajustable.
f) **Dispositivos de apoyo**. Aparatos para ejercitar piernas, tronco y brazos, pasamanos, barandillas, barras y asideros, reposabrazos.
g) Dispositivos **para abrir y cerrar puertas, ventanas y cortinas**: sistemas de control remoto (domótica) productos de apoyo para accionar o controlar los dispositivos de apertura y cierre.

h) Elementos **para la construcción en el hogar y otros locales**: grifos monomando, dispositivos de apertura y cierre de ventanas, productos para controlar la iluminación.
i) Productos para la **accesibilidad vertical**: grúas, productos de apoyo para la elevación (ascensores, plataformas elevadoras) rampas, orugas para escaleras, escaleras de tijera y de mano.
j) Equipos de **seguridad para el hogar y otros locales**: materiales antideslizantes para suelos y escaleras, válvulas de seguridad de gas, vallas de seguridad, materiales táctiles para suelo, útiles para la orientación de personas con déficit visual.
k) Muebles para **almacenamiento.** Almacenar piezas y herramientas de trabajo (armarios, mesillas, botiquín, archivadores y estanterías).

3.3. PRODUCTOS DE APOYO PARA LA MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS Y BIENES

Esta es una categoría muy amplia y abarca todo tipo de acciones que puede necesitar una persona para manipular objetos de manera fácil y sencilla: coger, mover, dejar, recolocar, cargar... Se divide en las siguientes subcategorías.

a) **Materiales y herramientas para marcar**: signos, etiquetas, productos para elaborar etiquetas en Braille o dispositivos para localizar objetos mediante un sonido.
b) Productos de apoyo para **manipular recipientes**: para agarrar y fijar, para abrir botes, para extraer el contenido de los recipientes.
c) Productos de apoyo para **accionar o controlar dispositivos**: botones, interruptores, pulsadores, volantes, manivelas...
d) Productos de apoyo para **controlar a distancia**: sistemas de control remoto para el control del entorno.
e) Productos de apoyo para **reemplazar las funciones del brazo, mano o dedos**: dispositivos para agarrar, porta objetos, soportes, varillas para manejar los tableros de comunicación, dispositivos para manejar los ordenadores (licornios pulsadores...)
f) Productos de apoyo **para alcanzar a distancia**: pinzas de largo alcance eléctricas y manuales.
g) Productos de apoyo para la **colocación**: para colocar objetos cerca de la persona para que pueda alcanzarlos.
h) Productos de apoyo para la **fijación**: por ejemplo una hoja de papel a una mesa o para mantener un libro abierto, tapetes antideslizantes, ventosas...
i) Productos de apoyo para **reposicionar y levantar**: permiten levantar objetos pesados (raramente se utilizan en el hogar).

j) Productos de apoyo para **cargar y transportar**: carritos para transportar objetos, carros de la compra, mesas con ruedas, dispositivos para transportar bicicletas y remolques para coches.
k) Vehículos de transporte industrial: carretillas elevadoras, furgones, camiones..No se emplean en atención domiciliaria.
l) Grúas.

3.4. PRODUCTOS DE APOYO PARA MEJORAR EL AMBIENTE, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Dentro de esta categoría se incluye todo tipo de maquinaria, herramientas y dispositivos (herramientas manuales y eléctricas) para mejorar el entorno en el que se desenvuelve la persona. Tales como productos para reducir el ruido, para controlar la iluminación, purificadores de agua, instrumentos de medida, básculas para pesar alimentos, termómetros para mediar la temperatura ambiental, herramientas para realizar trabajos manuales, productos de apoyo para la movilidad personal (sillas de ruedas y andadores) así como maquinaria que ayude a la movilización de la persona (sillas salvaescaleras, grúas y sillas para baño...)

3.5. PRODUCTOS DE APOYO PARA EL ESPARCIMIENTO

Es importante que las personas puedan tener la posibilidad de disfrutar de actividades de ocio y de tiempo libre. Debido a limitaciones físicas, sensoriales y/o cognitivas, es posible que la persona en situación de dependencia precise de apoyo para satisfacer esta necesidad. Se clasifican en:

a) **Juguetes**: Ej. guante con pala de pimpón sujeta a la palma, que permite agarrarla sin necesidad de hacer presión, resulta muy útil para personas con discapacidad motora.
b) **Juegos**: incluye juegos de ordenador y otras actividades con normas establecidas, por ejemplo baraja de cartas Braille, baraja de cartas de grandes dimensiones,
c) Productos de apoyo para **ejercicio y deporte**. Facilitan la realización de actividades deportivas a las personas con discapacidad, por ejemplo un balón con cascabeles para personas con déficit visual.
d) **Instrumentos musicales** para la estimulación sensorial.
e) Productos de apoyo para **reproducir fotos, películas o vídeos** entre otros productos destacan los dispositivos adaptados para realizar vídeos.
f) Herramientas, materiales y equipo **para manualidades**, un ejemplo un enhebrador de agujas de coser.
g) Herramientas, materiales y equipo de **jardinería.**
h) Productos de apoyo para **la caza y la pesca**, por ejemplo cañas adaptadas para personas con un solo brazo.

i) Productos de apoyo para **acampar**, por ejemplo una plataforma para acoplar la caravana y permitir el descenso de una silla de ruedas.
j) Productos de apoyo para **fumar**, dispositivos que permiten sujetar el cigarrillo a través de un tubo flexible.
k) Productos de apoyo para el **cuidado de animales domésticos**, por ejemplo dispositivos para colocar la comida dirigido a personas con dificultad para agacharse.

3.6. ORDENADORES PERSONALES. INTERNET. CORREO ELECTRÓNICO

El uso de ordenadores puede ampliar las posibilidades comunicativas y de relación de las personas con dependencia que reciben ayuda en el domicilio y con ello contribuir a minimizar los sentimientos de soledad y el riesgo al aislamiento, además de mejorar su autoestima y la percepción de su calidad de vida.
Para ello los equipos informáticos deben ser accesibles, es decir, adaptados a las características cognitivas, sensoriales y funcionales de cada persona. Para ello habrá que facilitar el manejo de herramientas que les puedan resultar útiles y atractivas. Algunas de las adaptaciones son: pantalla táctil, teclas grandes y con aumento de la separación entre ellas, teclados ergonómicos, ratones especiales, varillas bucales, punteros manuales: mano, pie, muñón o mentón, apoyo de antebrazo o muñeca.

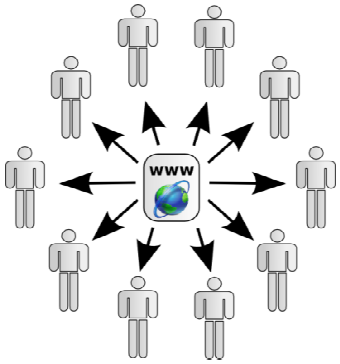
Internet es una puerta al exterior, a través de él los usuarios pueden mantenerse informados, consultar el estado de sus cuentas bancarias, realizar compras, comunicarse con personas, intervenir en foros de temas de su interés. Todo ello repercute positivamente en su bienestar general.
Existen diferentes recursos que se pueden utilizar para interactuar con otras personas a través de Internet: chat, foros, blogs, redes sociales y el correo electrónico.



a) El correo electrónico permite enviar y recibir cartas electrónicas, a diferencia del correo ordinario, la comunicación es casi instantánea.

b) CHAT es una forma de comunicación a tiempo real mediante mensajes escritos. Las personas ciegas pueden utilizarlo con las adaptaciones precisas en el ordenador. También puede utilizarse cámara web, esta tecnología resulta especialmente práctica para la personas sordas, pues pueden comunicarse con Lengua de Signos (LS).

c) Los **foros** son espacios de discusión, opinión y debate sobre múltiples temas, a diferencia del chat, la comunicación no es en tiempo real. Resulta imprescindible registrarse (igual que en el chat) y permite que las intervenciones sean anónimas. Resulta muy interesante para las personas con dependencia, pues pueden contactar con personas que comparten sus mismos intereses, dificultades, informaciones necesarias, recursos; estos foros pueden ser interesantes también para familiares y cuidadores.



d) **Blogs**: cada uno está gestionado por la persona que lo ha creado con el fin de reflejar sus opiniones, gustos, experiencias.

e) **Redes sociales** son páginas que permiten generar vínculos con personas conocidas y además establecer nuevos contactos con los que compartir información (datos, fotos, vídeos..). Es un tipo de aplicación que integra correo electrónico, chat y foros.

3.7. OTRAS AYUDAS

La norma UNE-En-ISO 9999-2007 incluye además otros productos de apoyo encaminados al cuidado y la protección personal.

a) Productos de apoyo para **tratamiento médico personalizado**: Incluyen productos adaptados para terapia respiratoria (respiradores, aspiradores), terapia circulatoria (medias antiedema), fototerapia (lámparas ultravioletas), diálisis (unidades para hemodiálisis) administración de medicinas (jeringuillas, pistolas de inyección) y esterilización de materiales. También se encuentran dentro de esta subcategoría test para la evaluación cognitiva, cojines y soportes para la prevención de úlceras por presión y otros productos para la rehabilitación.

b) Productos de apoyo para el **entrenamiento/ aprendizaje** de capacidades: se incluyen productos para terapia y entrenamiento en la comunicación alternativa y aumentativa, productos de entrenamiento en funciones cognitivas, en habilidades sociales, en manejo de dispositivos de las AVD.

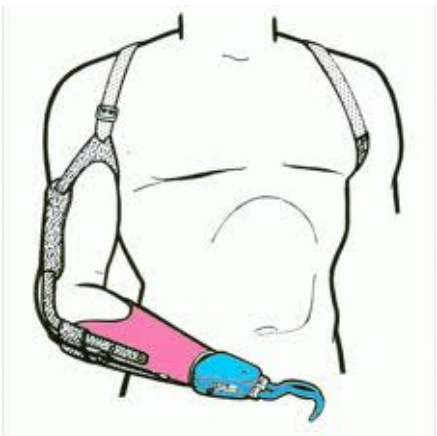
c) **Ortesis y Prótesis**: son productos que se colocan en el cuerpo externamente para mejorar o sustituir los órganos y funciones corporales naturales.

- Ortesis: modifican las características físicas o funcionales del sistema neuromuscular o esquelético (no sustituyen ni órgano ni miembro afectado). Por ejemplo:



- **Prótesis:** sustituyen parcial o totalmente las partes del cuerpo que no funcionan correctamente o que han sido amputadas. Por ejemplo : pelucas, prótesis dentales, prótesis mamarias,







d) Productos de apoyo para el **cuidado y la protección personal**, son aquellos productos destinados al cuidado y bienestar físico de la persona. Incluye todos los productos relacionados con el vestido (velcro, cremalleras...), higiene personal (sillas para la ducha, adaptadores para el cepillo de dientes...), productos para el control de esfínteres, cuidado

de traqueotomía, termómetros, básculas de voz, dispositivos para ayudar en las relaciones sexuales (vibradores, productos para ayudar en la erección..)

e) Productos de apoyo para **la movilidad** personal, son aquellos que facilitan la movilidad a la persona: Andadores, sillas de ruedas, vehículos motorizados manejados por el usuario, tablas de transferencias, discos de transferencias, plataformas elevadoras, bastones para personas con discapacidad visual.

f) Productos de apoyo para la **comunicación y la información**, aquellos productos que ayudan a recibir, procesar y elaborar la información y le permiten comunicarse con su entorno. Incluye productos para ver, oír, escribir, dibujar, calcular y leer. Además se incluyen en esta subcategoría los accesorios para el ordenador (teclados y ratones adaptados, línea Braille, impresoras Braille) hardware y software adaptados.

El profesional de ayuda a domicilio debe de conocer todos los productos de apoyo que existen para ayudar a minimizar las dificultades que las personas con dependencia pueden tener en la realización de las actividades cotidianas pues ello tendrá repercusiones en su autoestima y bienestar personal.

En la siguiente web tienes el catálogo del CEPAT donde aparecen de todos los productos de apoyo.

http://www.catalogo-ceapat.org/

5. MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE DE LAS PERSONAS MAYORES, CON DISCAPACIDAD O ENFERMAS

4.1. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA MOTIVACIÓN Y EL APRENDIZAJE DE LAS PERSONAS MAYORES, CON DISCAPACIDAD O ENFERMAS

Las personas conservamos la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida. La adquisición y asimilación de nuevos conceptos, habilidades, actitudes, ...no sufren alteraciones significativas por el paso de los años. Lo que sí cambia es la capacidad sensorial, que afecta al modo de percibir el entorno, los cambios cognitivos en el procesamiento y almacenamiento de la información, y la motivación personal (los intereses) de cara a la adquisición. Aprendemos

constantemente, aunque a veces las RUTINAS nos hacen sentir seguros y nos cuesta asimiliar nuevas cosas.

En las personas mayores, personas con dependencia o con enfermedad, es probable que la capacidad de aprendizaje y la motivación se vean afectados, y esto repercute en su estado de ánimo.

Vamos a **definir algunos conceptos básicos**:

4.1.1. LA MOTIVACIÓN

Es la fuerza o impulso que nos empuja a realizar una acción o a percibir una situación como interesante.

Dos categorías dentro de la motivación:

- **Motivos primarios**: los que guardan una relación con las necesidades corporales (hambre, sed, sueño, temperatura corporal, sexo..) y con la adaptación al entorno (evitar el dolor y el peligro, manipular objetos..). son innatos y muy importantes para la supervivencia.

- **Motivos secundarios**: los relacionados con aficiones, con el poder, con los logros. Son aprendidos y dependen del contexto donde viva la persona.

La motivación también puede ser I**NTRÍNSECA**, es decir que surge en el interior de la persona (realizar una actividad por puro placer, por ejemplo las aficiones deportivas) son más duraderas y efectivas. Y pueden ser **EXTRÍNSECAS,** son externas a la persona, por ejemplo obtener una recompensa si se realiza una actividad (por ejemplo un premio por hacer la cama) o evitar un castigo (por ejemplo llegar pronto a casa para evitar que me dejen sin paga).

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.

Las personas con dependencia presentan unas características especiales que pueden afectar a su motivación y aprendizaje. Tendremos que analizar cómo influyen las alteraciones sensoriales, las habilidades cognitivas, la capacidad adaptativa, los sentimientos depresivos etc.. porque todo ello influirá en la motivación de la persona. Una motivación escasa provocará que la persona no quiera aprender cosas nuevas e incluso que deje de hacer actividades que ya había aprendido.

Aunque las caracterísricas de la motivación de una persona estarán determinadas por sus características personales, historia vital y proceso de

dependencia, por lo tanto no es adecuado generalizar, si que podemos señalar las **características de la motivación de las personas con dependencia**:

- Escasa motivación y energía.
- Motivación intermitente, puede aparecer y desaparecer si no ve consecuencias positivas.
- Orientada a cubrir las necesidades básicas. En los casos más graves puede desaparecer la motivación incluso para satisfacer estas necesidades.
- Suelen presentar comportamientos conservadores y tienen dificultades para incorporar motivaciones nuevas a sus conductas.

Estrategias para motivar a estas personas:

- Minimizar las dificultades que puedan tener para realizar las actividades.
- Valorar los rasgos positivos y destrezas de la persona con dependencia.
- Identificar las motivaciones de cada persona, teniendo en cuenta sus limitaciones.
- Enfatizar los beneficios de la actividad.
- Plantearse metas a corto plazo y metas alcanzables, posibles de realizar
- Emplear refuerzos externos sin olvidar los internos.
- Informar, asesorar y enseñar a la persona dependiente los recursos existentes a su alcance.

4.1.2 EL APRENDIZAJE

Características específicas del aprendizaje en distintos colectivos:

- **EN PERSONAS MAYORES**

CARACTERÍSTICAS:

- Requieren más tiempo para procesar y retener la información.
- La capacidad de concentración y la atención es menor , y resulta fundamental para el aprendizaje.
- La capacidad para percibir los estímulos y procesarlos está condicionada. por déficits sensoriales o cognitivos.

INTERVENCIÓN:

- Dar instrucciones claras y precisas.
- Darles más tiempo para reaccionar.
- Repetir la información si fuera necesario.
- Colocarnos de frente a ellos.
- Utilizar nombres en lugar de pronombres.
- La información más importante darla al principio de la frase.
- Acompañar el mensaje verbal de gestos o imágenes.
- Proporcionar un entorno tranquilo y estable.
- Buscar un aprendizaje activo y significativo para ellos.
- Buscar actividades del interés de la persona.

- **EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL**

CON PROBLEMAS **VISUALES:**
- Presentar imágenes grandes y sencillas.
- Utilizar colores vivos y con contraste.
- Utilizar materiales auditivos.

CON DÉFICIT **AUDITIVO:**
- Utilizar imágenes.
- Lectura labial si es posible.
- Lengua de signos (LS).
- Situarse frente a ellos, vocalizar pero sin exagerar.
- Reducir el ruido ambiental.
- Motivar a utilizar otros canales de información que no estén afectados.

- **EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL**

CARACTERÍSTICAS:
- Dificultad para mantener la atención.
- Dificultad para discriminar los estímulos.
- Lentitud para procesar la información y emitir una respuesta.
- Dificultades de comprensión y expresión.
- Dificultad para generalizar los aprendizajes.
- Poca curiosidad e iniciativa.

INTERVENCIÓN:
- Explicar las actividades de forma sencilla y detallada.
- Asegurarse de que se ha comprendido.
- Proponer tareas sencillas donde pueda tener éxito.
- Darle tiempo.
- Evitar imponer.
- Mantener una actitud tranquila y amable que de confianza.
- Felicitar, alabar, reconocer lo que ha realizado bien le harán afrontar otras tareas (Refuerzo positivo).

- **EN PERSONAS CON ENFERMEDAD**

CARACTERÍSTICAS
- dolor, cansancio, debilidad, inseguridad, ansiedad.

INTERVENCIÓN:
- Procurar que esté cómodo.
- Favorecer los medios para evitar el dolor o minimizar el malestar.

- Procurar estímulos que eviten centrarse en su enfermedad, por ejemplo ayudándole a fijarse objetivos personales vitales.
- Hacerle consciente de que él es el protagonista y no la víctima.
- Planificar sesiones cortas y en el momento del día que esté más animado y activo.
- Proporcionar los productos de apoyo necesarios.
- Reforzar positivamente cada avance.

Las técnicas que favorecen el aprendizaje están centradas y orientadas a fomentar la actividad cerebral (cerebro activo). Entre ellas:

- Leer, sin importar el qué ni cuánto.
- Resolver "asignaturas pendientes", es decir, iniciar el aprendizaje de algo nuevo que siempre interesó, pero que no pudo realizarse por falta de tiempo u otros motivos.
- Practicar juegos que obliguen a pensar y a recordar.
- Relacionarse con otras personas para poder conversar acerca de temas actuales o pasados.

4.2. MANTENIMIENTO Y ENTRENAMIENTO DE LAS FUNCIONES COGNITIVAS EN SITUACIONES COTIDIANAS DEL DOMICILIO.

El cerebro humano es un órgano que, como el resto, si no se usa puede atrofiarse. De modo que cuanto más estimulado se encuentre, más óptimo será su rendimiento. **Las funciones cognitivas** son aquellos procesos por los que la persona recibe, almacena y procesa la información relativa a uno mismo, a los demás y al entorno. A veces, pueden confundirse alteraciones en estas áreas con el simple aletargamiento de ellas por falta de uso y estimulación.

Muchas veces hacemos cosas en el lugar de la persona que ella es capaz de hacer por sí misma debido a la prisa y el ritmo de vida que llevamos. Sin embargo, es imprescindible que todas estas tareas, las siga realizando la persona, aunque no las haga de la manera adecuada o le lleven más tiempo. Es así como continúa ejercitando tareas motrices, cognitivas,... El domicilio es un entorno familiar que facilita este mantenimiento cognitivo y funcional.

Las personas que requieren asistencia domiciliaria pueden tener afectadas las funciones cognitivas en diferente grado y por diferentes razones (edad avanzada, enfermedad, deterioro progresivo, inmovilidad física, déficits sensoriales...) El profesional debe conocer cuáles son las características de las funciones cognitivas y debe entrenarlas con el fin de que se mantengan el máximo tiempo posible, lo cual repercutirá en la autonomía y la calidad de vida del usuario.

Los objetivos que deben plantearse en la intervención de las funciones cognitivas:

- Prevenir: evitar el deterioro de las funciones cognitivas.
- Mantener: intentar que perduren las funciones que aún conserva la persona.
- Ralentizar: frenar el deterioro de las funciones cognitivas.
- Recuperar: intentar que el usuario recobre funciones que antes poseía a partir de la estimulación y los ejercicios planificados.

Pero para alcanzar estos objetivos no es necesario implementar todo un programa de estimulación cognitiva con materiales complicados. Basta con aprovechar las actividades que realizamos a lo largo del día (mientras acompañamos en la comida, en el aseo personal, la propia relación y conversación que se realiza con la persona ya le lleva a mantener un cierto nivel de estimulación cognitiva (atención, memoria, lenguaje,...). Así mismo, el diseño de los espacios, la decoración, etc. ayudará a mantener al usuario ORIENTADO y CONECTADO a la realidad.

En el siguiente punto se verán distintas actividades que se pueden realizar en el domicilio para ejercitar cada una de las áreas afectadas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no existen actividades propias de estimulación concreta, ya que todas las tareas cognitivas estimulan varias funciones mentales.
Es necesario que las actividades se adecuen al nivel cognitivo y sensorial de la persona: una actividad excesivamente simple no potenciará su actividad cerebral, más bien aburrirá y desmotivará a la persona. Por el contrario, una actividad demasiado difícil puede frustrar, desmotivar enojar y mermar la autoestima (sobre todo en las primeras fases de deterioro cognitivo en las que la persona es consciente de sus limitaciones). Por lo tanto, la tarea debe ser tal que exija un mínimo de esfuerzo cognitivo (si no, no se estimula), sea de interés para la persona, significativamente relevante y que tenga en cuenta las preferencias y el nivel previo de conocimiento y nivel cultural de la persona.

En definitiva, todas las actividades que realizamos a lo largo del día son actividades con las que practicamos y mantenemos nuestra capacidad cognitiva, como por ejemplo, preparar la lista de la compra para realizar una comida determinada no deja de ser una tarea de planificación, lenguaje, atención, secuenciación, etc.

Estrategias a tener en cuenta a la hora de plantear la intervención en el entrenamiento de las funciones cognitivas en el domicilio:

- **Informar y motivar** a la persona sobre los beneficios del mantenimiento de las funciones cognitivas y su repercusión en la autonomía personal.
- Utilizar **materiales y utensilios familiares**, objetos que conozca: utensilios de cocina, de aseo, alimentos, ropa, revistas y periódicos, fotografías, puzzles y pasatiempos, objetos personales.

- Elegir el **momento apropiado**: ambiente tranquilo, descansado, si vemos que está irritado lo dejaremos para otro momento.
- Planificar **sesiones breves** (que no excedan de 45 minutos). Si alguna actividad le disgusta se realizará otra.
- Mantener una actitud de **respeto**, procurando un clima cordial y de confianza, adaptándonos a los ritmos del usuario evitando órdenes o presentando las actividades como obligaciones.
- Facilitar un **entorno lo más ordenado** posible (cada cosa en su sitio).
- Utilizar elementos que faciliten la recuperación de la información como **agendas**, cuadernos donde apuntar citas, tareas, recados…
- Utilizar **pastilleros** semanales para evitar los olvidos y las dudas sobre si se ha tomado o no la mediación
- Colocar **calendarios** en lugares visibles y mantenerlos actualizados (por ejemplo tachando los días pasados). También es útil un tablero de orientación sobre el año, estación acontecimientos importantes…
- **Organizar las cosas**. Por ejemplo: colocar las llaves, el abono del transporte en un lugar en la entrada de la casa para no olvidarlas.

Una de las técnicas más empleada para intervenir en las funciones cognitivas es la **ORIENTACIÓN A LA REALIDAD (OR) 24 horas**, también llamada "orientación informal a la realidad". El objetivo es mantener a la persona orientada a lo largo del día en sus actividades cotidianas, pero sin llegar a desbordarle con información, sin agobiarle. También responderemos a preguntas que nos puedan realizar los usuarios " ¿qué día es hoy?, ¿qué voy a hacer ahora?¿quién eres?".
Ejemplo **OR 24 horas:**

- Saludo: "buenos días, soy Lucía, la auxiliar, ¿qué tal noche ha pasado?. Hoy es miércoles 24 de mayo, son las 9 de la mañana, hace un día precioso de primavera. Ahora voy a ayudarle en el aseo, después le ayudaré a vestirse y luego le acompañaré a desayunar".

*La cantidad de información y el ritmo dependerá del usuario con el que trabajemos.

Otra forma de entrenar las funciones cognitivas es a través de sesiones estructuradas de OR. En ellas dedicaremos un tiempo a trabajar las referencias que le permitan mantener su orientación en el espacio y el tiempo, así como su orientación personal, además trabajaremos la atención, la memoria, el lenguaje y el cálculo.

Un ejemplo de **una sesión estructurada de OR:**

- Saludar por el nombre y verbalizar lo que se va a hacer.

- Informar del día de la semana, del mes, de la estación, de las festividades o acontecimientos próximos, recordar el lugar donde nos encontramos (pueblo, calle, provincia..).
- Realizar ejercicios para trabajar diferentes funciones cognitivas: percepción, atención, memoria, razonamiento. Por ejemplo ante una lámina de dibujos localizar los iguales, o localizar determinadas formas.
- Comentar la sesión realizada: qué le ha parecido, cómo se ha sentido, En este momento el auxiliar debe aprovechar para reforzar "hoy te he visto seguro" "lo has hecho muy bien" " has conseguido recordar 4 palabras"..
- Recordar el tiempo y espacio: "por hoy hemos terminado, ¿te acuerdas de qué día es?, ¿ y de en qué mes estamos?..."

Despedida hasta la siguiente sesión.

4.3. MEMORIA, ATENCIÓN, ORIENTACIÓN ESPACIAL, TEMPORAL Y PERSONAL, RAZONAMIENTO

4.3.1. LA MEMORIA

Es una de las funciones cognitivas más importantes, gracias a ella podemos construir una imagen mental de quiénes somos a partir de nuestros aprendizajes, vivencias , y recorrido vital.

Cuando una persona tiene problemas de memoria, los recuerdos van desapareciendo, dejan de reconocer a seres queridos, habilidades antes aprendidas se olvidan..., con lo que la identidad de la persona también se desvanece.

La memoria es una facultad variable y por lo tanto se puede y se debe intervenir para mantenerla y mejorarla. Por ello debemos conocer las fases que la componen para saber de qué forma y en qué momento tenemos que actuar.

En la memoria intervienen tres pasos o Fases:

1. Registro 2.Retención 3.Recuperación de la información

- **1. Fase de Registro. (Memoria Sensorial)**

Es la fase en la que se capta la información.
El tipo de memoria que interviene es la llamada **memoria sensorial o inmediat**a. Lo importante en esta fase es conseguir almacenar y conservar la información que nos llega a través de los sentidos, para ello la percepción y la atención son esenciales.

La estimulación sensorial aumentará la capacidad perceptiva. En el ambiente hay gran cantidad de estímulos, pero sólo percibimos unos cuantos (aquellos que son de nuestro interés: por ejemplo si tengo un brazo escayolado, continuamente veo a personas con miembros escayolados, si estoy sacando el carnet de conducir, veo cantidad de coches de autoescuela... Aquellos que son muy llamativos: alguien que va disfrazado sin ser carnavales... Cuanto mayor sea la sensibilidad perceptiva, mejor se guardará la información en la memoria.

El sentido de la VISTA es uno de los más utilizados a la hora de captar la información de lo que nos rodea, por lo tanto deberemos realizar ejercicios de estimulación visual.

- **Ejercicios de estimulación sensorial VISUAL**

- Semejanzas y diferencias: Comparar figuras geométricas y captar diferencias de colores, forma, tamaño.
- Colores: Captar los colores de la ropa de los usuarios y personal del centro, de los personajes de una revista nombrándolos y diferenciándolos,...
- Búsqueda visual: Captar una determinada forma o figura o la ausencia de la misma en una escena real o imagen. Por ejemplo: partes que le faltan a un dibujo, figuras geométricas que se repiten, pedirle que localice una imagen.
- Descripción: Describir un objeto o persona (cuidador, compañero..).

- **Ejercicios de estimulación sensorial AUDITIVA**

Ejercicios para mejorar la percepción AUDITIVA (importante para registrar la información).

- Identificación auditiva: Reconocer sonidos (campana, lluvia, tambor, puerta, timbre, motor...) identificar la voz de los compañeros del grupo...
- Repetición: Repetir sonidos que haya escuchado previamente. Repetir secuencias de golpes que se dan sobre una superficie, palmadas, con instrumentos musicales...
- Discriminación: Prestar atención a sonidos emitidos, palabras complejas, frases y especificar a que sonido hay que prestar atención (por ejemplo en una canción cuando se dice una palabra concreta...)

- **Ejercicios de estimulación sensorial TACTIL**

Ejercicios para la estimulación del TACTO, realizaremos ejercicios de identificación y de percepción de las características táctiles.

- Identificación: Algunos ejercicios: adivinar un objeto a través del tacto con los ojos cerrados. Identificar diferentes partes del cuerpo, identificar un objeto que se encuentra dentro de una bolsa. Normalmente empleamos objetos comunes (conocidos)
- Percepción de características tactiles: Captar la temperatura, textura, dureza de un objeto. Para ello podemos emplear objetos de diferentes materiales: cartón, madera, tela, cristal...

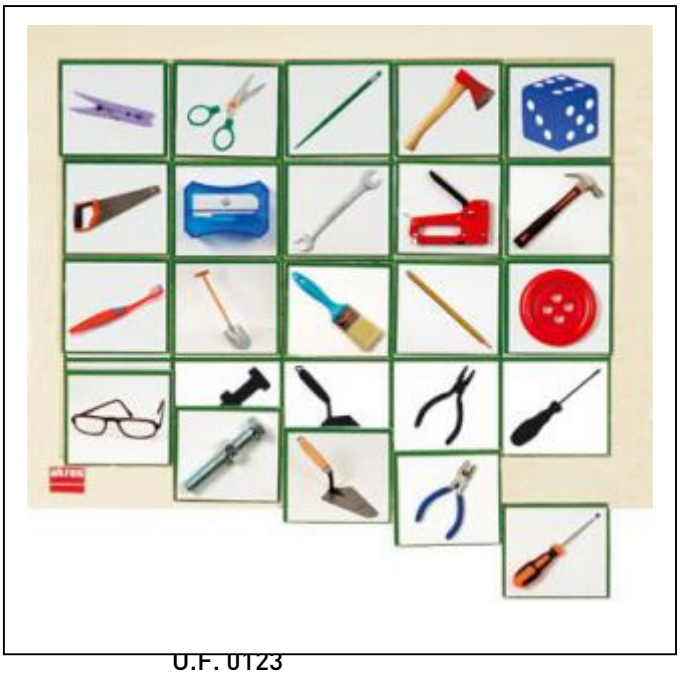
- **Ejercicios de estimulación sensorial OLFATIVA**

- Identificación: Se presentan diferentes olores para que se identifiquen (alimentos, plantas,...agradables y desagradables...).
- Discriminación: Se presentan varios olores al mismo tiempo y la persona tiene que discriminar cada uno de ellos.
- Evocación: Se escoge un olor y se pide al usuario que recuerde un lugar, un acontecimiento personal ligado a ese olor (ejercicio libre).

- **Ejercicios de estimulación sensorial GUSTATIVA**

- Identificación: Daremos a probar diferentes alimentos y les pediremos que digan lo que es. Además podemos aprovechar para que lo asocien a algún acontecimiento y que comparen los sabores.
- Discriminación: Daremos a probar (dulce, salado, ácido, amargo) para que comparen y citen ejemplos de alimentos con estos sabores.

Ejemplos de materiales para la estimulación sensorial (visual, táctil...)







- **2. Fase de Retención.**

En esta fase lo importante es que la información se organice para que se fije en la memoria. Para organizar la información podemos seguir un orden racional, o irracional y estar basado en la experiencia o en el lenguaje. Las técnicas son:

- Estructuración intelectual
- Asociación
- Visualización
- Lenguaje

- **Estructuración intelectual**: organizamos la información de forma racional (utilizando el razonamiento). Por ejemplo pedimos al usuario que haga una frase con palabras desordenadas para que tenga un sentido lógico. Otro ejemplo; le damos una lista de la compra (pan, champú, cepillo de dientes, tomate, lejía, papel de cocina, espuma de afeitar, detergente) y le pedimos que la ordene en distintas categorías:

Alimentos	Productos de limpieza	Productos aseo personal

- **Asociación:** se trata de establecer una conexión o relación entre los elementos a recordar y diversas experiencias, imágenes o sonidos significativos. Las asociaciones pueden ser muy diferentes de unas personas a otras porque dependen de sus vivencias y experiencias anteriores.

Las personas pueden realizar las asociaciones que se les ocurran, si utilizan imágenes para recordar, mejorará el recuerdo.

Por ejemplo. Si les damos una serie de palabras para que recuerden: "toro", "melón", "Francia", "sandía" "melocotón" "perro" "Alemania", probablemente las recordarán si las agrupan en categorías, por ejemplo: "Toro" con perro" (animales) Francia con Alemania (países), sandía con melón y con melocotón (frutas). (Países, animales, frutas, asocian las palabras por categorías diferentes).

Existen varias técnicas de asociación por ejemplo la técnica de LOCI o técnica de los lugares, el usuario visualiza un lugar conocido y coloca en él los objetos que desea recordar (por ejemplo para recordar una lista de objetos de aseo personal, se pide al usuario que imagine el cuarto de baño y ubique los objetos a recordar). Cuanto más llamativas sean las imágenes que visualice más fácil será recordarlas. Así por ejemplo, si tiene que realizar una compra de manzanas, el periódico y el pan, podría imaginar una barra de pan enorme leyendo el periódico en la sala de la residencia y que habla con una manzana.

Otra técnica por asociación consiste en crear una historia a partir de unas cuantas palabras que les pedimos que recuerden. Por ejemplo si tiene que recordar las palabras: perro, coche, gafas y ciudad; podría imaginar la siguiente historia: un perro con gafas se dirige a la ciudad en coche.

- **Visualización** es una técnica mediante la cual cualquier palabra, objeto, persona o situación puede ser recreada en una imagen mental. Esta imagen hará que se recuerde mejor. Nos puede ayudar a recordar un lugar donde hemos estado, para mejorar la técnica asociaremos a la imagen visual temperatura, colores. Esta técnica como las anteriores potencia la RETENCIÓN de la información.
  Ejemplo: pediremos a los usuarios que creen una imagen mental con diferentes palabras: juez, salvaje, amor, libertad...

- **El lenguaje:** introduce la información en la memoria a través del sonido y del significado de la escritura. El lenguaje se aprende en la primera fase de la vida y se refuerza constantemente, pues participa en todas las comunicaciones con otras personas. Para mantenerlo y usarlo habrá que cuidar su comprensión y producción, lo cual lograremos a través de ejercicios, como por ejemplo:
  - Reconstruir palabras a partir de sus letras desordenadas, por ejemplo:

EJERCICIO	**SOLUCIÓN**
ZNMAANA	MANZANA
LACBAAZ	CALABAZA
VHUOSE	HUEVOS

  - Realizar crucigramas

- Realizar pirámides: se da una palabra, y hay que ir quitando una letra y formando palabras nuevas, hasta llegar a palabras de 2 ó 3 letras.
- Comenzando con una palabra, ir cambiando una letra para formar nuevas palabras:
  - **EJERCICIO** **SOLUCIÓN**
  - **CASA** **CARA**
  - **CARA**
  - **CERA**
- Leer un texto y responder a preguntas sencillas
- Pedirles que lean un texto breve y extraigan las ideas más importantes.
- Recordar una lista de palabras.

- **3. Fase de Recuerdo.**

Es la fase en la que recuperamos la información que previamente hemos almacenado. A veces ocurre el efecto de "lo tengo en la punta de la lengua", esto es, se tiene la información guardada, pero no se puede acceder a ella. Para ello utilizaremos las siguientes técnicas:

- Referencias espaciales y temporales: que consiste en ubicar los recuerdos en un espacio (lugar) y en un tiempo.
- Integración asociativa: que consiste en utilizar asociaciones , pistas para recordar.

Lo importante es que los usuarios puedan conocer técnicas para evitar bloqueos, y así mantener activas las conexiones cerebrales.

Ejemplo de ejercicios:

- Decir palabras que empiecen por una letra o sílaba concreta
- Con varias letras usarlas como iniciales de palabras y formar frases.
- Con una lista de elementos, los usuarios deberán formar palabras con sus iniciales, por ejemplo si tienen que recordar "gafas" "teléfono" "oreja" y "almohada" tomarán sus iniciales y formarán una palabra "gato".

- **Tipos de memoria**

a) Memoria sensorial o inmediata: aquella que nos permite recordar la información que ha sucedido pocos segundos antes. La percepción y la atención prestada son esenciales.

Ejercicios para mantenerla y desarrollarla:

- Jugar a recordar objetos: se muestra un objeto y después se esconde, tienen que recordar qué era.
- Pedirles que recuerden los nombres de sus compañeros.
- Decir palabras por turnos y cada persona tiene que nombrar lo que la anterior ha dicho, se puede aumentar la dificultad teniendo que recordar varias palabras.
- Realizar un ejercicio de secuencia rítmica: palmadas, chasquear los dedos, … pedir que realicen la misma secuencia.
- Identificar olores con los ojos cerrados (cebolla, ajo, limón, café..).

b) Memoria a corto plazo ó Memoria de trabajo: permite recordar la información pasado un tiempo. Informa de lo que la persona está realizando en cada momento. Por ejemplo, recordar al ir a buscar un objeto cuál estoy buscando a pesar de entretenerme con otra cosa por el camino.

Ejercicios para mantenerla y desarrollarla:

- Recordar acontecimientos que han ocurrido a lo largo del día.
- Recordar las ideas principales de una reunión.
- Recordar los sucesos de una noticia.
- Reconocer una palabra que esté repetida dentro de una misma lista.
- Comparar dos columnas de palabras y encontrar aquellas que estén repetidas en la segunda.

c) Memoria a largo plazo : el tiempo que ha pasado desde que suceden los hechos hasta el momento de recordarlos es significativo. Por ejemplo, cómo fue su ingreso en la residencia hace dos años, cómo fue su matrimonio, recordar hechos de su infancia… Hay dos tipos de memoria a largo plazo:

- Memoria episódica: Se centra en los hechos o acontecimientos emocionales de la vida de las personas.
- Memoria semántica: Recopila el recuerdo de las cosas y los conceptos que aprendemos a lo largo de la vida.

Ejercicios para mantenerla y desarrollarla:

- Recordar los nombres de sus familiares, el lugar de nacimiento,
- Reminiscencia: que consiste en hablar sobre hechos importantes para el usuario, y que sucedieron hace tiempo. Por ejemplo, sobre su profesión, hechos de su juventud…la reminiscencia ayuda a mantener la autoestima personal.

4.3.2. LA ATENCIÓN

La atención es el filtro de la información previo al funcionamiento de la memoria, una función cognitiva importante para poder concentrarse en las actividades y así poder incorporar informaciones a través de la fase de registro de la memoria. Sin una adecuada atención es imposible la adquisición y memorización de la información. De hecho, en ocasiones suelen confundirse las alteraciones de atención con fallos de la memoria.

La atención es un proceso susceptible de ser trabajado y mejorado, y su estimulación redunda directamente en la mejora de la memoria.

No prestamos atención a todos los estímulos que nos rodean, porque no nos resultaría adaptativo, sólo nos fijamos en aquellos estímulos que para cada uno de nosotros resultan interesantes. Por ejemplo, si tengo un brazo escayolado, veo mucha gente también con brazos u otros miembros escayolados, si estoy sacando el carnet de conducir veo cantidad de coches de autoescuela...

Por lo tanto, los **factores que influyen en la atención**:

- por una parte, dependen de la persona: gustos e intereses, estado físico (como sueño, fatiga..), déficits sensoriales (audición, visión), déficits cognitivos, dificultades de concentración, alguna medicación.

- por otro lado dependen del propio estímulo: algo novedoso (lo diferente) llama nuestra atención, las AVD, que se han convertido en rutinas, pasan desapercibidas, por eso no recordamos si hemos cerrado la puerta con llave). La intensidad del estímulo (un sonido fuerte, colores llamativos, gran tamaño, ..)

Todos estos factores los tendremos que tener en cuenta para planificar el entrenamiento de la atención y conseguir que éste sea efectivo.

Ejercicios para mantenerla y desarrollarla:

- Localizar en un texto diferentes consonantes “x”,”D” “p” “q”.
- Señalar en un texto todas las palabras que empiecen por “B”.
- En una lámina de dibujos encontrar uno en concreto.
- Leer un texto y pedir a los residentes que se fijen en las cifras que aparecen (percepción auditiva).
- Jugar a palabras encadenadas.
- Al escuchar una canción realizar una actividad concreta cada vez que aparezca una palabra , por ejemplo “corazón”, “amor”, “clavelitos”.....
- Pedir que coloreen una figura concreta entre una serie de figuras

4.3.3 ORIENTACIÓN ESPACIAL, TEMPORAL Y PERSONAL

La capacidad para saber dónde estamos, quiénes somos o dónde nos encontramos es un proceso que, si se encuentra alterado, crea bastante confusión y alteración en la persona. Suele ser frecuente en procesos de enfermedad, tras ingresos hospitalarios y en las afecciones cognitivas, sobre todo si la persona se encuentra privada de información referente a ello (no sale a la calle, no escucha las noticias, no atiende a los calendarios).

La orientación es fundamental para poder estructurar el resto de los procesos cognitivos, ya que permite organizar la información en un tiempo y en un espacio.

Estas técnicas son muy beneficiosas para personas con deterioro cognitivo progresivo. En personas con grave deterioro cognitivo, puede ser contraproducente, ya que si se ve incapaz de realizarlas puede sentirse frustrado, con ansiedad. En ese caso, deberíamos ofrecer y crear rutinas temporales que puedan facilitarle la orientación en lugar de hacerle preguntas directas que no sepa contestar.

1. ORIENTACIÓN ESPACIAL

Es la capacidad de situarse en el espacio. Para poder hacerlo es necesario establecer unas referencias espaciales.

- Conceptos generales: izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos
- Entorno habitual: actividades que tengan como finalidad mantener a la persona orientada en el entorno sanitario.
- Orientación geográfica: actividades que tengan como objetivo ubicar a la persona en su país, comunidad autónoma, provincia, ciudad.

Ejercicios para mantenerla y desarrollarla:

- Ejercicios de manipular objetos para trabajar conceptos opuestos, por ejemplo, coloca la pelota roja dentro de la caja azul, tapa la caja amarilla con el pañuelo rosa y deja encima de todo esto la pandereta.

- Identificar las diferentes estancias de la residencia. Para ello mostraremos tarjetas con dibujos en las que aparecen diferentes AVD (comer, bañarse, dormir...) y deberán colocarlas en las estancias correspondientes.

- Trabajar puntos de referencia del entorno (de los alrededores). Para ello realizaremos un recorrido guiado por el jardín y otros lugares cercanos a la residencia, nos fijaremos en la puerta de salida, si giramos a la derecha, qué nos encontramos, por ejemplo un árbol, salimos por la puerta de la verja….Al finalizar el recorrido los usuarios deberán recordar las referencias nombradas.
- Ubicar la ciudad , provincia y Comunidad Autónoma en un mapa.
- Situar en un plano o mapa los lugares que han sido significativos en su vida.
- Realizar rutas sobre un plano; por ejemplo encontrar el camino para llegar desde la institución a la casa de un familiar.

2. ORIENTACIÓN TEMPORAL

Es la capacidad de situarse en el tiempo. Para poder hacerlo es necesario establecer unas referencias temporales:

- Conceptos generales: antes-ahora-después, ayer-hoy-mañana, día-mes-año.
- Rutinas habituales: actividades de la vida diaria (AVD) que le permitan situarse en el momento en el que está y así organizar las actividades que realiza (hora de comer, de cenar..)
- Fechas especiales: recordar los cumpleaños, Navidad, Semana Santa, carnavales y otras fiestas del centro.

Ejercicios para mantenerla y desarrollarla:

- Actualizar el tablero de orientación. Cada día un participante señalará el día numérico, día de la semana, mes, año y estación.
- Decorar las estancias comunes de acuerdo a la estación del año.
- Salidas al exterior para vivenciar las características de la estación. Color de los árboles, temperatura, nieve, flores…
- Poner la hora de la realización de las AVD, con tarjetas con dibujos que identifiquen las actividades, colocar la hora, ordenarlas secuencialmente.
- Ordenar secuencias desordenadas, bien de forma escrita o con fotografías o dibujos.
- Señalar en el calendario fechas relevantes. Recordarlas periódicamente.
- Elaborar en manualidades un calendario del mes en el que se encuentran y trabajar: ¿cuántos días tiene el mes? ¿?cuáles son los días de la semana?, fechas relevantes en dicho mes o fechas importantes para el usuario. De esta forma trabajamos también la memoria.

3. ORIENTACIÓN PERSONAL

Significa tener una representación de uno mismo: conocer su nombre, edad, pertenencia, reconocer a familiares.

- IDENTIDAD PERSONAL: se realizarán actividades dirigidas al conocimiento de la propia identidad: nombre, edad, profesión, características personales.
- RECONOCIMIENTO DE LOS OTROS: Actividades dirigidas a reconocer a personas allegadas, familiares, amigos, personal del centro.

Ejercicios para mantenerla y desarrollarla:

- Realizar juegos de presentación donde aportarán: nombre, apellidos, profesión, estado civil, aficiones etc..

- Reconocer la ropa que lleva puesta y saber cuál es la oportuna para la época del año en el que estamos. Diferenciar entre un montón de ropa cuál es de mujer y cuál de hombre.

- " Mi objeto es importante", se pide a los usuarios que lleven un objeto significativo y lo enseñe a los demás. Tendrá que explicar porqué es importante, qué vivencias a tenido junto a él. Con este ejercicio reforzamos la identidad de la persona como alguien único y a la vez trabajamos la reminiscencia.

- Ejercicios de reconocer a los familiares a través de fotografías, que recuerde las circunstancias de aquel día…

- Ejercicios para relacionar personas conocidas con sus ocupaciones y roles (Ana la psicóloga, Beatriz la animadora sociocultural, Begoña la médico…)

4.3.4. RAZONAMIENTO

El razonamiento es un proceso cognitivo propio del ser humano. Es la capacidad para organizar la información y elaborarla: permite mediante la atención, la memoria y el lenguaje extraer conclusiones y consecuencias de los acontecimientos observados, tomar decisiones y predecir futuros acontecimientos. Su deterioro puede dificultar el recuerdo de la información guardada en la memoria. Depende del entorno en el que se ha vivido, de las diferentes culturas, del entrenamiento en esta aptitud. Se puede dividir en verbal, numérico, viso-espacial y ambiental o adaptativo al entorno.

Las **principales técnicas para entrenar el razonamiento** son: La categorización, la seriación y establecer jerarquías, todas ellas refuerzan la información almacenada en la memoria.

- **Categorización:** consiste en ordenar una serie de elementos por un criterio común. Por ejemplo: cuchara, tenedor y cuchillo son ...CUBIERTOS, así agrupando los elementos en categorías nos resulta más fácil recordarlos.

Ejercicios:

- Ordenar la lista de la compra según la tienda donde haya que comprar cada producto: verduras, harina, pan, pescado, leche, galletas...
- clasificar palabras en categorías: cepillo de dientes, cama, sofá, toalla, cazuelas, papel higiénico...

- **Seriación:** consiste en ordenar elementos según una característica determinada: el tamaño, el color,... La seriación puede utilizarse para encadenar las AVD : levantarse, ir al baño, asearse, vestirse, desayunar

  Ejercicios:

  - Realizar una cadeneta de dos o más colores, alternándolos o siguiendo una secuencia (azul, amarillo, azul, amarillo....).
  - Ordenar piezas según el tamaño (de menor a mayor, de mayor a menor).
  - Nombrar series cotidianas: estaciones del año, días de la semana, meses del año...
  - Explicar la secuencia de alguna AVD .
  - Dar una secuencia de dibujos y el usuario tiene que adivinar cuál es el corresponde a continuación.
  - Proporcionar libros de diferente tamaño y pedirle que los ordene de mayor a menor.
  - Dar una secuencia de números y decir cuál es el que sigue, por ejemplo 1-4-7-10- ¿? (13, puesto que a cada cifra se le suma 3)

- **Jerarquización**: consiste en organizar los elementos en función del nivel de importancia, de urgencia.

  Ejercicios:

  - ordenar las actividades por orden de urgencia: asearse, ver la TV, cerrar el grifo del agua....

Todos estos ejercicios entrenan la capacidad de razonamiento de la persona, reforzándola y manteniéndola. Es importante realizar ejercicios que

correspondan al nivel del usuario para evitar la frustración si no es capaz de hacerlos. Será mejor plantear sesiones cortas y ejercicios que entrenen diferentes funciones para conseguir una buena concentración y disposición.

5. SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA

5.1. SERVICIOS, PROGRAMAS Y PROFESIONALES DE ATENCIÓN DIRECTA DOMICILIARIA A PERSONAS CON DEPENDENCIA: CARACTERÍSTICAS

Como el punto 2.2. de la Unidad Formativa 119

5.2. ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA AYUDA A DOMICILIO

Como en el punto 2.2.2. de la unidad formativa 119

5.3. EL EQUIPO INTERDISCIPLINAR

Como en el punto 2.2.3. de la unidad formativa 119